

MMPI (KES-YAPIŞTIR😊)

L ALT TESTİ:

69 T PUANI VE ÜSTÜ:Puanlamada hata yapılmış olabilir. ‘Yanlış ‘ yerine doğru cevaplar sayılmıştır.

2 farklı değerlendirme:

1-Bu kişiler sosyal açıdan kabul gören yanıtlar vererek kendini kontrol eden, etkili biri olduğu izlenimi bırakmaya çalışan kişilerdir.

2-Güvenilmez, pasif, uzak duran, kaygılı, içe kapanık kişilerdir.Diğerleriyle ilişki kurmaları zordur.Duruma özgü tepkileri yavaştır.L alt testindeki bu yükselmeye sık sık MMPI’ın nevrotik testlerindeki yükselme eşlik eder.

3- Az sayıdaki kişide ‘patolojik yalan söylemeyi ‘ gösterir.Bu klinik görünüm psikopat ya da manik hastalara özgüdür.

64-69 T PUANI:

Maddeleri gelişigüzel doldurma sonucu ortaya çıkabilir. Diğer geçerlik testleri incelenmelidir. Kişinin kendindeki zayıflıkları inkar ettiğini gösterir. Birey patolojik olarak kendini iyi göstermeye çalışmaktadır; represif (bastırılmış) ve savunucudur. Bu puanlar dini ve ahlaki inanç ve eğilimleri nedeniyle kendine aşır kontrol koyan bireylerde görülebilir. Ufak hatalarını bile inkar etmeye eğilimli onlalar, eğitimsiz olup kendini çok iyi göstermeye çalışanlar , inkar mekanizmasını sıklıkla kullanan histerik ve hipokondriaklar, azınlık grupları bu kategoriye girebilirler.

59-63 T PUANI:

Bireyin iyi görünme çabası içinde olduğu düşünülmelidir. Bunlarda sosyal açıdan kabul gören yanıtlar verme eğilimi vardır. Birey aşırı geleneksel ve sosyal açıdan uyumludur.

36-55 T PUANI:

Bu aralığa ilişkin özgün bir durum tanımlanmamıştır.

35 VE ALTI T PUANI:

Tüm maddeler doğrudur denebilir.Bağımsız, kendine güvenen, ufak sosyal hatalarını kabul etmeye hazır kimselerdir.Diğer geçerli alt testlerinin incelenmesi gerekir.İki farklı değerlendirme olabilir:

Birey ya kendini oldukça patolojik göstermeye çalışıyordur ya da bağımsız , kendine güvenen, eksikliklerden açıkça bahseden, sosyal kurallara önem vermeyen normal bir insan olabilir.

F ALT TESTİ:

80 T PUANI VE ÜSTÜ:F alt testi 90T puanını aşarsa bu profil dikkatli değerlendirilmelidir.Yükselme nedenleri şöyle olabilir:

- 1-İlişki kurmak istememe.Hepsi doğru ya da hepsi yanlış yanıt biçimi
- 2- Görme ya da okuma güçlüğü nedeniyle anlamada sorun ya da psikotik konfüzyon
- 3- Sahte kötülük.Eğer hastanın kendisini kötü göstermede kazançları varsa bu durum ortaya çıkmaktadır. Mahkumiyet,malulen emeklilik...gibi nedenlerle simülasyon yapma.
- 4-Yardım çağrısı profili.2 ve 7 testleri 6,8 ve 9 testlerinden yüksektir.
- 5-Eğer 1 ve 4 alt testleri dışlanırsa açık psikoz ya da ciddi psikopatoloji vardır.6 ve 8 testleri yükselmiştir.Düşünce bozukluğuna veya ilişkili klinik semptomlara bakınız.

70-80 T PUANI:Bireyin ego işlevselliğinde bozulma olduğunu, ilişki kurmak istemediğini ya da yanlış anlaşıldığını düşünmesinin göstergesidir.

- 1-Bu aralık psikozdaki hastaları ya da ciddi nevrotik bozukluğu olan kişileri göstermektedir.
- 2-Bireyin alışılmadık ve geleneksel olmayan düşünce biçimi vardır.
- 3-Antisosyal ve asi kişilerdir.
- 4-F alt testinin bu aralıktaki yükselmesine nevrotik ve psikotik testlerdeki yükselme de eşlik ediyorsa birey borderline bir durumdadır.

55-69 T PUANI: Birey bu aralığın üst sınırlarında ise negativist,değişken,huysuz ve huzursuzdur .Çeşitli tanı grupları bu aralığa girebilir:
Akut nevrozlar ve kişilik bozuklukları
Durumsal stresi olan bireyler.
Savunucu psikotikler

45-54 T PUANI:Birey sadece belirgin maddelere yanıt vermiştir.

- 1-İlgi alanı daralmıştır.
- 2-Bireyin psikopatolojiyi,duygusal gerginliği gizlemek istediğini ve direncini gösterir.(Sahte iyilik)Bu hipotezi L ve K alt testlerindeki yükselme de desteklemektedir.

44 ALTI T PUANI:Bireyin savunucu olduğunun göstergesidir.Birey herhangi bir psikopatoloji, gerginlik ya da stresi olmadığı görünümünü vermek istemektedir.(‘Sahte iyilik’)

K ALT TESTİ:

72 T PUANI VE ÜSTÜ:Savunucu bireylerdir.Kendilerinde psikolojik sorunlar olduğunu kabul etmezler.Esnek değillerdir.Tedaviye yanıt kötüdür.

61-72 T PUANI:Bu kişiler kendilerinde ve çevrelerinde olan olan bozuklukları en aza indirme ve görmezden gelme eğilimindedir.Savunmalar artmıştır,içgörü azdır.Histerik savunmaları olan nevrotikler için uygundur.Genelde hipokondriyaklar ve histerikler dışında kalan nevrotikler değerlendirmede savunmalarını göstermezler.Savunmalar abartıldığında bu düzeyde bir yükselme elde edilir.

46-60 T PUANI:Bu düzeydeki puanlar dengeli bireyleri göstermektedir.Bu yükselme bireyin ego gücünün iyi olduğuna, olumlu kendilik değerine ve uyuma işaret etmektedir.Bunların psikolojik müdahaleyi istemek için yeterli kişisel kaynakları vardır.Yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen hastalara psikolojik tedavi yarar sağlayabilir.Klinik testler yüksek olsa bile, böyle bir K alt test puanı, bireyde uygun bir başa çıkma becerisi olduğunu gösterir.

27-45 T PUANI: Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen bireylerde gözlenebilir. Bu hastalar sınırlı kişisel kaynakları ile açıkça ortaya koydukları ciddi sıkıntıları yaşamaktadırlar. Hastaların zayıf kendilik değerleri vardır ve kendilerinden hiç memnun değillerdir. Ancak durumlarını değiştirecek gerekli kişiler arası beceri ve niteliklerden yoksundurlar. Alt sosyo-ekonomik düzeyden hastalarda bu yükselme orta düzeyde bir hastalığı yansıtırken, yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip hastalarda düşük ego gücü ve daha ciddi sıkıntıyı yansıtır.

1-Ergenlerdeki düşük K puanı sıklıkla onların kimliklerini araştırmasından dolayı olabilir. Benzer bir durum içgörü yönelimli terapiye devam eden bireylerde kendilik değerlerini sorgulamalarında da görülür.

Orta ve üst düzeydeki hastalarda rahatsızlık akuttur. Ego gücü düşmüştür. Savunmalar uygunsuzdur.

2-Genellikle kendini teşhir etme eğilimi içinde olan bireyler, yardım almak isteğiyle sorunlarını abartan kişilerdir.

3-Hastaneye yatmayı gerektiren akut psikotik sıkıntı yaşayan bireyler olabilirler.

KLİNİK ALT TESTLER

1-(Hs) HIPOKONDRIAZİS:

84'ÜN ÜZERİNDE T PUANI: Yakınmaları bütün organ sistemlerine yayılmış olan kişilerde görülür.Ağrı,yorgunluk ve güçsüzlük sıklıkla vardır.Somatik ilgiler somatik delüzyonlara dönüşmüş demektir.Bu belki de şizofrenik bir epizodun başlangıcıdır.

75-84 T PUANI: Bedensel yakınmalar ile çok fazla uğraşan bireylerde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak iş yapma istekleri azalmıştır, yakınmalarının bedensel kaynağını sürekli bir biçimde araştırırlar. Sıklıkla benmerkezcil ve narsisistiklerdir, sürekli şikayet eder ve sızlanırlar. Yakınmalarını diğerlerine kabul ettirme eğilimleri çok fazladır, bu nedenle aşırı talep edici bir tutum içindedirler. Çevrelerindeki bireyleri rahatsız ederek öfkelerini ortaya çıkarırlar. Tipik olarak inatçı, kötümser, genel olarak da yaşamda mutsuz, tutkusuzdurlar ve güdülenmemişlerdir.

60-74 T PUANI: Bu puanlar sıklıkla bu kişilerin hem şimdiki, hem de geçmiş yaşantıda fiziksel bozukluk gösterdiğine işaret etmektedir ve bu yükselmeye sıklıkla D alt testindeki yükselme işaret eder. Sağlık konularına bu ilgi, basit olarak yapıcı bir ilgi olabilir ya da sağlığa aşırı duyarlılığı temsil eder. Böyle kişiler kötümser olmaya ve yaşamlarını sıkıcı hale getirmeye eğilimlidirler. Bedensel hastalığı olan bireylerde 65T puanının üstünde bir yükselme bu bireylerin yaşadıkları güçlüklerle aşırı tepki verdiklerini ve kabul edilmez dürtülerini somatizasyon ile ifade ettiklerini göstermektedir.

50-59 T PUANI: Bu kişilerin beden konuları ile aşırı ilgilenmediği ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirdiği söylenebilir. Bu kişiler sıklıkla yetenekli, sorumluluk sahibi, vicdanlı, dikkatli ve yargılamaları iyi olan kişilerdir. Spesifik tıbbi hastalığı olan bireyler bu alanda yer almaktadır.

21-49 T PUANI: Bu durum şu kişilerde görülebilir: (a) Hastalığın hiç konu olmadığı ailelerde yetişen bireyler (b) Şimdiye kadar hiç ağrı, acı ya da hastalık geçirmediği ile övünen kişilerde. Ayrıca bu kişiler hipokondriyak olarak hastalıklarını manipülatif yolla kullanan aile üyeleriyle yakından ilişkili olabilir, ancak burada normal acı ve ağrılar da inkar edilir. Bedensel yakınmaları ve genel sağlık durumları ile çok az ilgilenen kişilerdir. Genellikle uyanık, iyimser, yeterli ve yaşamda etkin olan kişilerdir.

Sadece Hs alt testinin yükselmesi: Bu hastalar belirsiz fiziksel yakınmalar getirirler ve bunları diğer kişileri kontrol ve manipüle etmek için kullanırlar. Bu hastalar her şeyi kötü gören, sızlanan, ilgi çekmek isteyen kişilerdir ve genellikle olumsuz ve kararsızdırlar. Bu hastalara müdahaleler genellikle fazla güven vermez.

Hs KODLAMALARI

12/21 Kodu

Bu kodun en belirgin özelliği bedensel rahatsızlık ve ağrıdır. Bireyler bedensel işlevleriyle çok fazla ilgilidir. Genel olarak hipokondriyak yakınmaları, somatizasyon bozukluğu ya da psikofizyolojik reaksiyon şeklinde kendini gösterir, stres dönemlerinde daha da belirginleşir. Semptomlarının duygusal çatışmalarla ilgili olduğunu ve bunları kullanarak psikolojik sorunlarından kaçmaya çalıştıklarını anlamak istemezler. Yakınmaları belirsizdir ve medikal olarak ayrıştırılması zordur. Hipokondriyak özelliklerinden dolayı herhangi bir tıbbi müdahale olabildiğince kısıtlı olmalıdır.

Bu kodu veren lise öğrencileri genellikle, utangaç, gergin, içedönük, mutsuz, endişeli, güvensiz ve özellikle karşı cins ile ilişkilerinde oldukça çekingendirler.

Üniversite öğrencisi ergenler, sıklıkla utangaçlıklarını obsesyonlar ya da sosyal izolasyon biçiminde gösterirler. Bağımlılık ve karamsarlık belirgindir ve arkadaşları azdır Aile öykülerinde sıklıkla ayrılıklar ya da boşanma vardır.

12 kodunda 1 ve 2 alt testleri arasında 5T puanı kadar fark varsa 21'e bakılır;

Bu kişiler fiziksel semptom ve yakınmalarını dile getirir,bedensel işlevlerine aşırı ilgi gösterirler.Genel olarak belirgin organik bir patoloji yoktur.,ancak az da olsa var olan fiziksel sorunlarını abartma eğilimi gösterirler.Anlatışları çok sayıda somatik yakınma arasında baş ağrısı, mide ağrısı sırt ağrısı gibi ağrılar ; kardiak yakınmalar ya da anoreksiya, bulantı, kusma, ülser gibi gastrointestinal zorluklar odak noktasını oluşturur.Sinirlilik,huzursuzluk ve depresyonun eşlik ettiği yorgunluk, zayıflık ve baş dönmesi vardır.

Hastalar, yakınmalarını kullanma ve yaşam biçimi haline getirmeyi öğrendikleri için tedavi edilmeleri zordur, kısa süreli tedaviye cevap verebilirler, ancak semptomları geri döner. Bedensel semptomlarının psikolojik sorunlardan kaynaklandığını reddederler.İçgörülleri oldukça sınırlıdır.

Duygularını ifade etmeleri güçtür ve bu nedenle özellikle öfke gibi olumsuz duyguların gösterileceği durumlarda kendilerini huzursuz hisseder ve öfkeyi somatizasyonla gösterirler.

Olası Tanı: Pasif-bağımlı kişilik bozukluğu
Somatizasyon bozukluğu
Depresyon

123/213 Kodları (Ayrıca 1234 ve 1237'ye bakınız. 3 alt testi, 1'den 5T puanı yüksekse 213/231 kodlarına bakınız.)

Bu kişiler özellikle yorgunluk, güçsüzlük ve karın bölgesindeki organlarla ilgili bedensel yakınmalar gösterirler. Öykülerinde uzun süreli kronik hipokondriasis öyküsü vardır. Onların yakınmaları sıklıkla pasif bir bağımlılığın kanıtı olabilir ancak bu kişilerde konfüzyon,intihar düşünceleri,obsesyonlar ve kompulsiyonlar yoktur.İlgi alanları daralmış,depresif,atılğan olmayan,risk alma konusunda tereddütlü kişilerdir

Ek olarak Pd alt testi düşük olduğunda heteroseksüel ilişki azlığı ve seksüel zorlukların olduğu bir pasifliği gösterir. Ma alt testinde de düşüklük olduğunda kişide enerji düzeyinde azalma, iş yapmama ve sürekli yatma isteği vardır.

Mf alt testinin düşmesi kadınlarda aşırı derecede sorumluluk aldıklarını ve sıkıntılarının uzun süreli olduğunu gösterir. **Eğer aynı zamanda L alt testi de yükselmişse** bu kadınlarda evlilik sorunları, yorgunluk yakınmaları ve diğerleri tarafından anlaşılmamam vardır.

Olası Tanı: Belirgin somatizasyon bozukluğu ve hipokondriak uğraşlar.

1234 Kodu(Ayrıca eğer alt tes 1 ve 2 diğerlerinden 5 T puanı yüksekse 2134'e bakınız.)

Kişilerde kişilik zayıflığı korkaklık, stres yaratan durumlarla ve sorumluluklarla başa çıkmada yetersizlik vardır. Bağımlılık,bağımsızlık çatışması yaşarlar.Atılğan davranışlalar zayıflıklarını kapatma çabasına girerler.Rahatlamak için alkole sığınır,ancak içtikleri zaman kavga ederler.Bu profili veren erkekler kadınlara karşı düşmanlık duyguları gösterirler(Sıklıkla fiziksel şiddet yani dayak vardır).Özellikle güçlü bağımlılık gereksinimleri engellenmiştir.

Erkeklerde anneye bağımlılık özlemi, anneleri tarafından reddedilme korkusu ile çatışma içindedirler.Olası tanılar; pasif -agresif kişilik, anksiyete,ya da psikofizyolojik reaksiyonlardır.

Kadınlarda karakter bozukluğu, pasif-agresif kişilik, kimseye güven duymama duygularını ifade etme güçlüğü ya da nasıl ifade edeceğini bilememe görülür. Psikoterapide savunucudurlar, motivasyonları düşüktür.

Olası Tanı: Pasif-agresif kişilik
Anksiyete ya da psikofizyolojik reaksiyon

1236 Kodu

Birey uzun süreli gerginlik, yetersizlik ve stres altında semptom geliştirme eğilimi gösterir.Semptomlar konversif niteliktedir.Bastırma ve yadsımayı kullanır.Olumsuz duygularını psikosomatik semptomlarla gösterir.

1237 Kodu

Bu profili veren bireyde anksiyete,gerilim,korku,atılğan olamama,yetersizlik duyguları ve kişilerarası ilişkilerde bağımlılıkta artma vardır.Genel olarak buna psikofizyolojik hastalıklar eklenir.Sırt ve göğüs ağrıları ve epigastrik yakınmalar vardır.**Özellikle K 50 T punaından düşükse** bu kişiler, günlük stres ve sorumluluklarla başa çıkamazlar.Erkekler kendilerinden daha güçlü kadınlarla evlenirler ve bu ilişki ile bağımlılık rolünü sürdürmeye çalışırlar.Kronik işsizlik ve alkol bağımlılığı görülebilir.

Olası Tanı: Pasif bağımlılık kişilik yapısında anksiyete ve psikofizyolojik reaksiyon

1270 Kodu

Birey, sinirlilik, anksiyete, depresyon, zayıflık, yorgunluk, ilgi kaybı gibi semptomlar gösterir. Benlik değerlerinde düşme vardır.Sosyal ilişkilerinde geri çekilme ve içe dönük tutum sergilerler.Uykusuzluk, kardiyak semptomlar ve anoreksiya görülebilir.

12378 Kodu

Nevrotik bozuklukların daha şiddetli şeklidir.7 ve 8'deki yükselmeler, nevrotik bozukluğun daha abartılı olduğunun göstergesidir.

128/218 Kodları

Sıklıkla bu profil bedenin üst kısmına ilişkin bizar yakınmalar getiren kişilerde görülür ve genel olarak buna yorgunluk, gerilim ve düşüncelerde bozulmalar eşlik eder. Ruhsal bozukluk ve diğerlerinden yabancılaşma gösterirler.Genel olarak bu kişiler, akut prepsikotik ya da psikotik ve somatik delüzyonlar gösterirler.

129/219 Kodları

Bu kişiler beden işlevleri ile aşırı ilgilenirler ve hastalıklarının gerçekten acil olduğunu düşünürler. Akut klinik rahatsızlık, gerginlik, ajitasyon, huzursuzluk belirgindir. Baş ağrısı, uykusuzluk ve spastik bağırsak ağrıları yakınmaları sıktır. Nörolojik etyoloji de dikkate alınmalıdır, çünkü organik beyin sendromlarında da benzer yakınmalar görülebilir. Çok az düzeyde de olsa bu kişiler depresyonu, çatışmayı ve/ya da hipomanik tarzdaki pasif-bağımlı tavrı maskeleyebilir ya da inkar etmeyi isterler.

120/210 Kodları

Bireyde depresyon, iç çekilme, karasızlık, kişilerarası ilişkilerden kaçınma, yetersizlik ve suçluluk duygularına değişik somatik yakınmalar eşlik eder.

8 ve 6 birlikte yükselmişse uzak duruş, pasif ve insanlardan kaçan şizoid bir biçim gösterirler.

13/31 Kodu

Bu alt test hem normal, hem de psikiyatrik hastalarda görülür. Bu hastalar genellikle immatür, benmerkezcil ve bağımlıdır. Histerik özellikleri vardır. Dikkati kendi üzerlerinde toplamayı ve ilgi çekmeyi isterler ve bunu oldukça manipülatif bir biçimde yaparlar.

Hastalar, psikolojik sorunlarını somatik yakınmalar haline dönüştürürler. Bu somatik yakınmalarında psikolojik etkenlerin de olabileceğini kabul etmezler, stres altında fiziksel semptomlar gösterirler. Yakınmalarında genellikle ikincil kazanç vardır (Histeriden çok hipokondriyak özellikler gösterirler). Bu bireylerin bedensel yakınmaları, spesifik ve net olmamakla birlikte beraber genellikle baş, göğüs, sırt ağrısı, uyuşma, el ve ayaklarda aşırı titreme şeklindedir. Sıklıkla yorgunluk, baş dönmesi, uyuşukluk ve titreme görülür. Ayrıca bu kişilerde yemek yemekten rahatsızlık ve bulantı gibi yakınmalar olabilir, bazen anoreksiya ve bulimiya görülür.

13/31 kodu ile birlikte 2 ve 7 testleri normal sınırlar içinde ise de bu profili veren birey bastırma, inkar, rasyonalizasyon ve projeksiyon mekanizmalarını aşırı bir biçimde kullanır. Nadiren olumsuz kızgınlık duyguları gösterirler ve bu duyguları ile yüzleşmekten kaçınır ya da pasif agresif bir biçimde davranır. Karşı cinsten kişilerle ilişki kurma, bu bireyler için bir gereksinim olsa da genellikle zordur ve bu konuda genelde başarısız olurlar.

13/31 kodu ile birlikte 2,7,8 ve 9 alt testleri yükselmiş ve K alt testi düşmüşse hastada gerginlik, anksiyete, karar vermede güçlük ve depresyon olabilir. Sorunların varlığına rağmen birey semptomlarından rahatsızlık duymaz. Semptomlarda kısmi azalma bile günlük yaşamlarını devam ettirme imkanı verir. Kendilerini normal ve sorumluluk sahibi tanımlama eğilimi vardır.

13/31 kodu ile birlikte L ve K alt testleri de yükselirse, kendilerine ile uğraşılmasına karşı öfkeli oldukları anlaşılmaktadır.

13 kodunu veren kişilerde hipokondriyak özellikler belirgindir. **31 kodunu veren kişilerde ise** stres durumları ile karşılaşıldığında bedensel yakınmalar ortaya çıkar, immatür ve bağımlı özellik gösterirler. Terapi sırasında sorunlarına hemen çözüm isterler. Semptomların temelinde yatan psikolojik nedenleri kabul etmedikleri için geleneksel psikoterapiye

dirençlidir. Terapide kesin cevaplar ve çözümler olmazsa terapiyi başlangıç aşamasında bırakırlar. Ayrıca terapistin kendilerinin aşırı ilgi beklentilerini hemen doyurmadığını düşünürlerse de terapiyi sonlandırırlar.

İçgörülerini yoktur. Bedensel yakınmalarının psikolojik kaynaklı olduğuna ilişkin yorumlara çok dirençlidirler.

Hastalardaki bedensel semptomlar onlara ikincil kazanç sağlar. Diğer kazançları ise sorumluluk almama ve görevden kaçmadır.

13/31 Kodu, Yüksek K

Özellikle 2,7 ve 8 testlerinin T puanı 70'in ve F alt testi T puanı 50'nin altında ise bireyler kendini normal, sorumluluk sahibi, yardımsever ve sempatik olarak sunmaya çalışır. Var olan herhangi bir bedensel semptomun ortaya çıkma biçimi yetersizlik, değersizlik şeklindedir. Geleneksel psikoterapötik müdahalelerden yararlanmazlar, profesyonellere güven duydukları zaman tedaviyle iyileşebilirler.

13/31 Kodu/Düşük 2 Kodu

Bu tür profil veren bireylerin, histerik kişilik özellikleri vardır ve kalsik psikosomatik semptomlar gösterirler.

132/312 Kodları

13/31 kod tipindeki özelliklere ek olarak birey, zayıflık ve yorgunluktan yakını (Eğer 9 alt testi de düşükse). Kendilerinde depresif duygudurum olduğunu inkar etseler de davranışlarında sıklıkla depresif özellikler vardır. Bu kişiler uyumlu ve pasiftirler (Özellikle 4 alt testi düşükse). Diğerlerinin ilgisi karşısında endişe yaşarlar. (Si alt testinde düşüklük olduğunda bile).

134/314 Kodları

Bireylerde belirgin olan özellikler; inatçılık, züppelik hatta kendini beğenmişliktir. Tanımlanan özellikleri nedeniyle somatizasyon yakınmaları ikinci planda kalmaktadır. 13/31 kodundaki özellikler bu bireylere de uygundur. Bağımlılık, bağımsızlık çatışmaları vardır; ancak diğerlerine yabancılaşma konusunda çok endişe yaşamazlar. Eğer profil konversiyon vadisine uygunsa somatik yakınmalar dönemsel patlamalar ya da pasif agresif bir tarzda ifade edilir.

1342 Kodu

Birey bağımlı ve immatürdür. Otistik dönemleri olabilir. Psikiyatrik olarak depresyon, anksiyete, sinirlilik, baş ağrısı, uykusuzluk gibi somatik yakınmalar görülebilir.

136/316 Kodları

Bedensel semptomların (özellikle mide ve baş ağrısı) stres durumlarında ortaya çıkmasına karşın bu kişiler, diğerlerinden gelen istekler karşısında gergin ve aşırı duyarlıdır. Bireyler benmerkezci ve narsisistiktirler. Ayrıca katı ve inatçı olma eğilimi içindedir. **Sıklıkla bu profil**

veren erkek hastalar rekabetçi, şüpheli, çabuk kızan ve diğerlerini kontrol etmeyi isteyen bireylerdir. Davranışlarını benmerkezci biçimde rasyonalize etme eğilimindedir, diğer insanlarla ilişkilerinde içgöruları azdır ve onlardan beklentileri çok fazladır.

Pa alt testi, Hy alt testinden 10 T puanından daha yüksekse şüphelilik ve kızgınlık oldukça belirgindir, olasılıkla erken paranoid şizofreniden şüphelenilir.

Hy alt testi, Pa alt testinden 10 ya da daha fazla T puanı yüksekse paranoid özellikler daha az belirgin olma üzere fiziksel yakınmalar ön plana çıkabilir.

137 Kodu

Bu profili veren kişi esnek değildir ve değişiklikler onu rahatsız eder. Genellikle iş ve para konularında değerlendirmeleri gerçekçi değildir. Eğer evliyseler eşleri yöneticidir. İş uyumları da bozuktur. Bu kişiler psikoterapiye isteklidir, ancak kendilerindeki saldırganlığı ve diğerlerine yönelik düşmanlık duyguları kabul etmek istemezler (özellikle alt test 4 düşükse)

Eğer Ma alt testi de yükselmişse ve/veya K alt testi 50 T puanından düşükse yukarıda sayılan özellikler daha da belirgindir. Anksiyete atakları çok sık olmamasına karşın özellikle sağlık ile ilgili konularda fobiler çok görülür.

138/318 Kodları

Bireyde duygudurumda bozulma vardır. Dini inançlarla aşırı ilgilidir ve delüzyonlar ortaya çıkabilir. Bunlara ek olarak belirsiz somatik yakınmaları ve oldukça garip fikir ve inançları vardır. Zaman zaman majör konversiyon reaksiyonları ve hipokondriak uğraşlar görülür ve bu şizofrenik reaksiyonu önleyebilir. Bu gruptaki kişilerin çoğunluğuna borderline kişilik bozukluğu tanısı konabilir. Ayrıca bunların çocukluk yaşantılarında ruhsal hastalık öyküsü olan bir aile ve/veya duygusal yoksunlukların olduğu bir dönem vardır. Erkeklerde homoseksüellikle ilgili korkular yaygındır, hatta buna karşı çıkmak için maskülen işler seçerler. Bu kişiler yapılandırılmış durumlarda daha iyi işlev gösterirler, yapılanmamış durumlarda ise garip semptomlar ortaya çıkmaktadır.

Olası tanı: Borderline kişilik bozukluğu

1382 Kodu

138'deki yoruma ek olarak dikkate değer depresyon, konfüzyonel düşünce, alkol alımı ve intihar etme düşünceleri vardır. Birey sıklıkla yalnızdır, evli ise evlilik uyumu bozuktur. Sürekli olarak bir işten , başka bir işe geçer.

139 Kodu

Bireyde; baş ağrısı, görme ve işitme yakınmaları, titreme ve koordinasyon bozuklukları ve çok sayıda somatik yakınma görülür. Engellenme eşiği oldukça düşüktür, sinirlidir ve öfke patlamaları vardır.

Eğer 4 alt testinde yükselme varsa ve K alt testi düşmüşse mücadeleci ve yıkıcı kişilik özellikleri vardır. Kişilerarası ilişkilerinde de öfke ön plandadır ve boşanmalar oldukça sık

görülür. Kişilerin genellikle mükemmelliği isteyen öyküleri vardır ve ailelerine ilgileri azdır. Alkol alımından sonra düşmanlık duyguları önplana çıkar. Bu kod çok sık olarak kişilik bozuklukları veya travmaya eşlik eden kronik beyin sendromu olan olgularda görülür. Seyrek olarak anksiyete bozuklukları ile birlikte.

Olası Tanı: Somatoform bozukluk
Organik beyin sendromu

14/41 Kodu

Erkeklerde kadınlardan daha sıktır. Benmerkezci, karamsar ve sızlanan kişilerdir. Hastaların hipokondriyak yakınmaları, özgün olmayan baş ağrıları biçimindedir. Sosyal açıdan dışadönük olarak görülmelerine karşın, karşı cinsle ilişkilerinde oldukça rahatsızlık yaşarlar. Aileye yönelik isyan duyguları olsa bile bunu ifade edemezler. Genel olarak aşırı alkol alımı tabloda görülür. Karşı cinsle ilişki sorunları tanımlarlar. Okul ve iş başarıları düşüktür. Kısa süreli semptomatik tedaviye iyi yanıt vermekle birlikte uzun süre tedavide kalamazlar.

Alt test 3 de birlikte yükselmişse, aile ve evlilik sorunları, kırgınlık ve sosyal yetersizlik duyguları ile birlikte bağımlılık ve bağımsızlık çalışmaları ön plana çıkmıştır. Sorunlarının psikolojik kökenli olabileceğini inkar ettikleri için tedaviye dirençlidirler.

Olası Tanı: Alkolizm
Daha seyrek olarak kadınlarda maskeli depresyon

Yüksek 1/Düşük 4 Kodu

Bu örüntü karşılaşılan sorunlarla başa çıkamama ve ev yaşantısındaki güçlüklerle bağlantılıdır. Öfkelerini kolaylıkla dile getirmelerine karşın yine de psikofizyolojik tepkiler verirler. Genele özellikleri sürekli yakınma ve karamsarlıktır.

146 Kodu

Antisosyal ya da impuls kontrolünde güçlüğü olan kişilerdir. Kötümser, katı, kolay ilişki kurulamayan, başkalarından gelen eleştirilere aşırı duyarlılık gösteren bireylerdir. Çevrelerini şaşırtacak derecede düşmanlık gösterirler.

1469 Kodu

Kızgın, tepkisel insanlardır. Aşırı biçimde karşılarındaki kişiyi suçlarlar. Hostil, huzursuz, alıcı, şüpheli, narsistik, benmerkezci kişilerdir. Duygusal labilite, anksiyete, gerginlik manipülatif, impulsif özellikler, eyleme vuruk davranışlar görülmektedir. İş başarısızlığı ve aile içi ilişki güçlükleri belirgindir.

15/51 Kodu

Yetişkin erkekler yakınan, telaşlı ve eleştiren ve temel olarak pasif bir yaşam biçimine sahiptir. Somatik alanda sorunlar getirirler. Genel olarak açık eyleme vuruk davranış yoktur. Nadiren açık çatışma ve kararsızlık gösterirler.

Bu kodda kadın hasta daha az görülmektedir. Orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen ve eğitilmiş kadınlarda karamsarlık yakınmaları oldukça fazladır.

Bağımlı gibi görünseler de kişiler arası ilişkilerinde yarışmacı ve saldırgan olma eğilimleri vardır.Bunları kontrol edebilmek için somatizasyon yakınmaları getirirler.Eğitim düzeyi düşük kadınlarda saldırganlık daha azdır.

Aslında hem kadınlarda, hem erkeklerde nadir olarak rastlanan bir koddur.Çok genel olarak erkeklerde 2,3,4 alt testlerinin de birlikte yükseldiği görülür. Ergenlerde ise çatışmalarını ya da sorunlarını ifade etme güçlükleri vardır.Sıklıkla kendilerinde bedensel hastalık olduğunu kabul ederler ve diğerleri ile bunu kullanarak ilişki kurarlar.Aslında çocukluk döneminde geçirdikleri bedensel hastalıkları vardır.Genç erkekler, genellikle kadını ve pasif olarak tanımlanır.

15/51 kodunu yorumlarken 5 alt testini bırakarak yükselen üçüncü alt teste bakama gereklidir.

16/61 Kodu

Bu bireyler katı inatçı ,eleştiriye açık, duyarlı ve diğerlerini suçlama eğiliminde olan kişilerdir.Her şeyi baştan savma eğilimindedirler, savunucudurlar ve duygusal ilişkiden endişe duyarlar.Genel olarak öfkelerini, rasyonalizasyonu ve yansıtmayı kullanarak gösterirler.Kontrollerinin çok fazla olmasına karşın bu gruptaki kişilerde (özellikle ergenlerde) şiddetli öfke patlamaları görülmektedir.

Alt test 8 de yükselmişse alışılmamış somatik uğraşların varlığı dikkate alınmalı, belki de somatik delüzyonların olabileceği düşünülmelidir.Bazı bireyler bedensel uğraşlarıyla ‘psikotik bir dönemden’ kurtulmaya gayret ederler.

Alt test 4’ün T değeri 70’den azsa;

Olası tanı: Paranoid Şizofreni

17/71 Kodu

Bu hastaların bedensel yakınmaları onların yaşadığı gerilim ve kaygıyı yansıtmaktadır. Yüksek enerji düzeyi ve ajitasyonla birlikte çoklu somatik semptomlar görülebilir.

Bireyde gerilimin yarattığı somatik yakınmaların yanı sıra anksiyete belirtidir. Genel oalrka bedensel işlevlerdeki bozuklukları ile obsesif bir biçimde uğraşırlar.Bu kod erkeklerde kadınlardan daha fazladır.

18/81 Kodu

Hastalarda düşmanlık ve saldırganlık duyguları vardır, ancak bu duygularını uygun bir biçimde ifade edemezler. Beden işlevleri ve bedensel hastalıklara ilişkin delüzyonel düşüncelerini açıkça gösterirler. Genellikle bizar tabiatlı somatik yakınmaları vardır.Somatik hezeyanları olabilir.Ayrıca somatik yakınmaları, gerçek psikotik yaşantının ortaya çıkmasına karşı savunmaları yansıtıyor olabilir.Bu kişilerde karşı cinsin üyelerine ilişkin hostilite vardır.Diğerlerine karşı güvensizlik,kendini onlardan kopmuş gibi hissetme, bu bireylerde uzaklaşma ve izolasyon ortaya çıkarabilir.Özellikle stres altında kişilerde şaşkınlık ve

düşüncede konfüzyon olabilir.Somatik uğraşları gerçek ile bağlantılarını koparabilir.Öfke ve hostilete duyguları belirgindir, ancak bunu açıkça ifade edemezler.

Tedavi sürecinde basit müdahaleler bu hastalara yetmez. Kişilerarası ilişkilerinde de içgörü sağlamaya yönelik yaklaşımlarla da yarar sağlanamaz.

Bu kod tipini veren ergenlerin okul başarısı düşüktür, unutkanlık oldukça fazladır. Baş ağrısı ve mide ağrısı gibi somatik yakınmaları vardır. Arkadaşları azdır. Hem okulda, hem de sosyal yaşamada uyumları bozuktur. Madde bağımlılığı ya da intihar girişimleri olabilir.Bu örüntüyü gösteren ergenlerin 2/3'ü boşanmış ailelerden gelmektedir.

Olası Tanı: Eğer F alt testi de yükselmişse şizofreni.
Pre-psikotik bozukluk tanısı da düşünülmelidir.

19/91 Kodu

Hastalar gergin ve kaygılı olarak tanımlanır. Çok yoğun duygusal karmaşa yaşarlar.Sindirim sorunları, baş ağrıları ve bitkinlik gibi bedensel yakınmalar yaygındır ve bu kişiler semptomlarına yönelik psikolojik açıklamayı kabul etmezler.Kendilerinden beklentileri çok yüksektir, ancak açık ve belirgin amaçları yoktur.Engellenme duyguları, kendileri için belirledikleri bu yüksek amaçları yerine getirememekten kaynaklanmaktadır.

Pasif- bağımlı bireylerdir, yetersizliklerini kompanse etmek isterler. Bu kod tipi aynı zamanda beyin hasarı olan bireylerde görülmektedir, kendi sınırlılıkları ve yıkımları ile başa çıkmada güçlükleri vardır.

Eğer bu profilde 2 ve 3 alt testlerinin değerleri 5T puanından aşağıda ise 129 ve 139 koduna bakınız:

Nadir olarak ortaya çıkan bu kod, akut psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde gerilim ve huzursuzluk ile birliktedir. Bedensel işlevler ve olası yetersizlikler ile aşırı ilgilidirler, hatta bu aşırı ilgi sözel olarak inkar etmeye ya da bedensel işlevlerdeki bozukluğu gizleme biçiminde ortaya çıkar .Burada endokrin işlevlerde ya da merkezi sinir sisteminde bir bozukluk olup olmadığı araştırılmalıdır.Bunlar yoksa o zaman maskeli depresyon olup olmadığına bakılmalıdır.Bu kişiler saldırgan ve dışadönük gibi görünseler de altta pasif ve bağımlı bir yapı vardır.Çoğunlukla 3 ya da 4 alt testlerinde yükselme görülür.

Olası Tanı: Organik beyin bozukluğuna bağlı güçlükler
Pasif-bağımlı kişilik bozukluğu

10/01 Kodu

Bu kod oldukça nadirdir, sosyal açıdan rahatsız, içe çekilmiş, soğuk, pasif kişilerde ortaya çıkar. Genel olarak bunlara bedensel yakınmalar eşlik eder.

Üçüncü yükselen alt test 8 olduğu zaman genellikle çok sayıda somatik yakınmalarla birlikte şizoid çekilme ve sosyal yetersizliğin olduğu söylenebilir. Sıklıkla 2 ve 3 yükselen

testlerdir ve eğer T değeri 70'in üstünde ise destek sistemleri zayıflamıştır ve maskeli depresyon vardır.

2-(D) DEPRESYON

85 VE ÜSTÜ T PUANI: Bir şeye odaklanamayacak ya da açık bir biçimde düşünemeyecek kadar kederli olan bireyleri gösterir.

79 VE ÜSTÜ T PUANI: Birey depresif ve kaygılıdır, benlik saygısı düşüktür. Genel olarak yaşama bakışı karamsardır. Tipik olarak ilgi alanları daralmış, morali bozuktur ve kendisini işe yaramaz olarak görür. Bu kişilerin duyarlılıkları kendi depresyonlarına ve fonksiyon düzeylerine yönelmiştir. Aynı zamanda kendilerini soyutlama ile içe çekilme görülür. Bu negatif yüklemeler kendilerinden hoşnut olmama sonucunu doğurur, bu da değişme isteği ile birlikte iyi bir prognoz sağlar. Yüksek puanlar sıklıkla somatik belirtiler ve yakınmalarla bir arada bulunur. Alt test 2'de yükselme, kişinin o sıradaki işlev düzeyiyle ilgili rahatsızlığı ya da hoşnutsuzluğu hakkında bilgi verebilir. Bu subjektif gerginlik anksiyete belirtisi olabileceği gibi gerçek bir depresif durum da olabilir. (yüksek puanlar her zaman depresyon olarak tanımlanamaz, kişinin o anada çevresinden gelen rahatsızlıklarını da yansıtabilir).

70-79 T PUANI: Ciddi ve kendine güvenli olmayan bireyleri gösterir. Eğer o ana durumsal baskılar yoksa ve özellikle L de yükselmiş ise bu bireyler, tipik olarak iyi ve kötü ya da doğru ve yanlış biçiminde düşünürler. Klinik olarak belirgin depresyonu olan bireyi gösterir. Bu bireyler en küçük bir şey karşısında bile endişe duyma eğilimi içindedirler. Psikiyatrik hastalar bu ranjda yer alırlar. Bu alanda bireyin yaşadığı huzursuzluk onun iyileşme için motive olduğunun göstergesidir. Hastada depresyonun göstergeleri yoksa ve diğer alt testler yükselmemişse hastanın intihar eğilimi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

60-69 T PUANI: Bu bireylerde orta düzeyde depresyon, endişe ve karamsarlık göstergesi vardır. Bu duygu durum hali, durumsal bir krize bağlı olabileceği gibi kalıcı ve geri dönüşü olmayan bir durum da olabilir.

45-59 T PUANI: Bu, bireyin yaşamında iyimserlik ve karamsarlık dengesini kurduğunun göstergesidir.

28-44 T PUANI: Olasılıkla neşeli, meraklı, iyimser, aktif ve dışa dönüktürler. (Bakınız Si alt testinin düşüklüğü) Bu durum bazen bu bireylerin kayıtsız gibi algılanmalarına neden olur, bu da diğerlerinde hostilite ortaya çıkarır.

Sadece D Alt Testinin Yükselmesi: Sadece D alt testi 70T puanının üstüne çıktığında birey reaktif bir depresyon yaşamaktadır. Yetersiz, güvensizdir, kendini cezalandırarak suçluluk duygularından kurtulma çabası içindedir ve çok fazla kaygılıdır, kendini eleştirir, sanki yaşadığı durum ya da bunu kontrol edememe için bir kefarete (ceza) ödeyecekmiş gibi. Birey depresif olduğunu (bu duygudurum başkaları için çok açık olabildiği halde) inkar edecektir. Psikoterapi prognozu genellikle kısa bir süre içinde iyidir ve bu tür hastalar yöneltici, yüzleştirici bir yaklaşıma iyi yanıt verirler.

Lise öğrencilerinde 2'nin tek başına 70T puanının üstünde olması; klinik olarak daha az anlamlıdır ve sıklıkla durumsal sorunlar genellikle karşı cinsle ilişkiler, ders çalışmada ya da mesleki seçenekler üzerindeki kaygıyı yansıtır.

Yüksekokul öğrencilerinde 2'nin tek başına yüksek olması; sorunlarının kökenine inme çabalarını reddederler ve bunun yerine ebeveyn yerine geçen birinden öğüt almaya çalışırlar.

D KODLAMALARI

21/12 Kodu (Eğer alt test 3, alt test 1'in 5T puanı alanı içindeyse 123/213 kodlarına da bakınız.)

Depresyon, gerginlik-kaygının daha ön planda olması dışında 12 koduna benzerdir. Depresyon genellikle apatiktir. 12 kodlarında olduğu gibi dışavurma görülmez (1234/2134 kodları hariç) Bu bireylerin psikoterapiden yarar sağlamaları güçtür. Bu kod, yaş arttıkça daha sıklıkla görülür ve erkeklerde kadınlardan daha fazladır. Sıklıkla test 3 ve 7, üçüncü en yüksek testlerdir.

23 kodu (Eğer uygunsa 213/231 kodlarına bakınız. Eğer alt test 3, alt test 2'nin 5 T puanı alanı içinde ise 32 kodlarına bakınız)

Bireyler kendilerini sıklıkla (özellikle düşük 9) zayıf, yorgun ya da tükenmiş hissedirler ve bunların depresyonu genellikle uzun sürelidir. Mutsuzluğu tolere ederler ve görevlere başlayamadıkları başladıklarında tamamlayamadıkları için düşük bir etkinlik düzeyinde fonksiyon gösterirler. Kod, histeroid savunmaların yetersiz kullanılması sonucu ortaya çıkar. Hastalar azalmış aktivite düzeyi, apati ve çaresizlik içeren depresyon gösterirler. Bu depresif semptomatoloji, histeroid mekanizma ve savunmaların yetersiz kullanımı sonucu ortaya çıkmış olabilir. Hastalar kişilik özellikleri olarak immatür, yetersiz ve bağımlı olarak tanımlanırlar. Kronik sorunlarına alışmışlardır ve yıllar boyunca bu azalmış etkinlik düzeyinde işlevlerini sürdürürler. Bedensel yakınmalar, sıklıkla histerik niteliktedir ve değişkendir.

Bu hastalar psikoterapiye dirençlidir, çünkü kronik sorunlarına nasıl uyum yapacaklarını öğrenmişlerdir ve en düşük etkinlik düzeyinde yaşamlarını devam ettirirler. Değişime ilişkin motivasyonları düşüktür.

23 kodlu erkekler görünüşte çok fazla başarı yönelimlidir ancak sıklıkla işlerinde fark edilmediklerinden yakınırırlar. Daha fazla sorumluluk isteyebilirler, ancak gerçekte istedikleri fark edilmek olduğundan bu sorumluluklardan da yakınırırlar. Bu koddaki bazı erkekler (özellikle 237 ya da 239 kodları) ciddi, gayretli, çalışkan ya da rekabetçi görünürler, ancak aynı zamanda da fark edilme istekleri açısından hem bağımlı, hem de immatürdürler.

23 kodlu kadınlar(özellikle düşük Mf ya da düşük Ma) zayıflık, apati ve belirgin depresyon gösterirler. Evde ve işte mutsuzluk ve genel bir etkin olamama hali kronikleşmiştir, ayrıca evlilik ve aile uyumsuzluğu öyküsü vardır.(Ancak boşanma sık değildir) Güvensizlik ve rahatsızlıklarına karşın yardım aramak için çok az çaba gösterirler.

Bu kod 25 yaşın üzerindekielerde daha sık ise de ergenlerde de görülür ve kötü arkadaş ilişkileri ile bağlantılıdır. Bu ergenler tipik olarak okul ortamında ve okul dışında çok az arkadaşı olan, yalnız bireylerdir.Genellikle pasif, uysal ve yumuşak başlıdırlar.Aile örüntülerinde, sıklıkla ilgisi sınırlı bir baba ve çok ilgili bir anne vardır.Cinsel eyleme vuruk davranışlar ve ilaç kötüye kullanımı, ergenlerde bu örüntü ile bağlantılı değildir.

Olası Tanı: Depresif nevroz

213/231 Kodları(Ayrıca 123 Koduna da Bakınız)

Yorumu 21 koduna benzerdir; ancak depresyon, durumun daha da önemli parçasıdır.Bağımlı, immatür bireylerdir, mutsuzluğu tolere etmeyi öğrenmişlerdir.Bu hastalar depresyonun yanı sıra baş ağrısı, göğüs ağrısı ya da bulantı ve kusma gibi hipokondriyak yakınmalar gösterirler.Ancak bunların depresyonu gülümseyen bir depresyon olabilir, yani bunlar ağlarken gülümserler, ancak neden olduğunu bilmezler.Kızgınlığı inkar ederler, ketlenmişlerdir ve abartılmış bir sevgi gereksinimleri vardır.Tipik olarak yakın aile üyelerinden çok az destek gördüklerini düşünürler ve bunların önemli bir kısmının çok genç yaşta iken ebeveynlerinden birini kaybetme öyküsü vardır.Duygusal olarak bağlanmada çatışma yaşamaktadırlar.Sempatı talebinde bulunmalarına ve semptomlarından ikincil kazançlar sağlamalarına karşın, çok fazla bağımlı olmaktan dolayı hoşnut değillerdir.Alt test 7 de yükseldiğinde endişe, klinik görünümün özel bir parçasıdır.

Olası Tanı: Depresif reaksiyon ya da somatoform bozukluk

24/42 Kodu

Bu tür profil veren hasta immatür, bağımlı ve benmerkezcidir. Dürtülerini kontrol etmekte zorluk çekmektedir, ancak şu anda depresyon, pişmanlık ve suçluluk yaşamamaktadır. Sosyal olarak kabul edilmeyen bir biçimde eyleme vurma davranışından sonra, rahatsızlık yaşar. Görünen suçluluk duygusu şiddetli olsa da (hatta olayla orantılı olmayacak kadar fazla) eyleme vuruk davranışlar, gelecekte döngüsel bir biçimde tekrarlanır. Aile ile ilişki sorunları, iş kaybı ve öyküsü bu örüntüye eşlik eder. İçki içme, madde kötüye kullanımı ya da alkolizm ve yasal sorunlar sıktır. Çoğunlukla 3,7 ya da 8 üçüncü yükselen testtir.

Bu örüntüdeki ergenler kabul edilmiş sosyal standartlara belirgin bir aldırmaçlık gösterirler, özellikle otorite figürlerine karşı küskün, tartışmacı, başkaları ile yakınlık kurmaktan korkan, suçlayıcı ve sıklıkla ilaç kullanan bireylerdir. Yasal ihlaller(tutuklanma, mahkumiyet, göz hapsine olma) geneldir, bunun yanında evden ya da tedavi merkezlerinden kaçma da görülür. Bu örüntüdeki çoğu ergenler kendilerini diğer aile bireylerinden uzaklaşmış hissederler, dayanılmaz ve çok çatışmalı ev ortamlarından kaçmayı isterler. Ebeveynleri şefkatsiz ve

tutarsız olarak algılarlar. Genellikle belirli bir şeye odaklanmada güçlükleri vardır ve okuldan kaçarlar.

Bu evlilik dışı çocuk sahibi olan kadınlarda sık görülen bir profil örüntüsüdür ve rastgele cinsel davranımla bağlantılıdır. Birey davranışlarını değiştirmek için kesin bir biçimde niyetli olabilir, ancak bu örüntü süregündür ve uzun sürede prognoz iyi değildir. Hızlı, geçici ilerleme gösterebilir, ancak yüzeysel değişikliklerden daha öteye gidecek tedavide kalamaz. Görünüşte saygılıdır, ancak terapide yüzleştirildiklerinde ya da zorlandıklarında tedaviye devam etmez, hatta sorunları ile uğraşmak yerine bulundukları şehri terk eder ya da iş değiştirirler. Genel de başkalarının kendilerinden beklentileri olduğunda kaçma, daha çok görülmetedir. Tedavide katı sınırlamalar, stratejik terapi yordamaları, sık görüşme ve çevresel düzenlemelerin bir arada kullanımı çok yardımcı olabilir.

Olası Tanı: Psikopatik kişilik bozukluğu tanısı konulan bireylerde duruma bağlı depresyon
Dürtü kontrol bozukluğu
Stres karşısında alkol ya da madde kullanımı

243/432 Kodları

24/42 kodundaki yorumlarda tanımlanan özelliklere ek olarak bu bireyler kızgınlığı bastırma ve inkar yoluyla duygusal kontrol etmeye çalışırlar. Kızgınlıklarını pasif-agresif biçimlerde ya da (eğer açıksa) öfke patlamaları biçiminde ifade ederler. İmmatürite, bencillik ve başkalarının onları nasıl gördüğüne ilişkin içgörü eksikliği vardır. Bu bireyler, eyleme vuruk davranışları olan uçlardaki bireylerle ilişki kurarlar ve bu nedenle de kendi antisosyal eğilimlerini başkası aracılığıyla tatmin ederler.

247/427/472 ve 742 Kodları(Ayrıca 274 koduna da bakınız)

Bireyin öfkesinden kaynaklanan aile ve evlilik sorunları vardır ancak birey bunu ifade edemez ve sonuçta suçluluk duyguları açığa çıkar. Gergin, endişeli ve sosyal açıdan yetersiz, depresyonu vardır. Depresyonlarını ortadan kaldırma çabası içinde aşırı alkol kullanımı ya da epizodik alkol alımları vardır. Bu bireyler genelde başarısızdırlar, olası başarısızlık nedeniyle herhangi bir şeyi denemekten korkuyor gibidirler. Sorunlarının açıkça görülmesine karşın bunları tartışmada samimi ve açık değildirler. Ayrıca, çok küçük problemlere aşırı tepki gösterirler ve bunlar sanki olağanüstüymüş gibi davranırlar.

Bu örüntüdeki erkekler, genellikle bağımlı ve immatür yapıda olmalarına karşın **(özellikle test 5 de yüksek ise)** sözel olarak saldırgandırlar. Evlilik sorunları vardır ve genellikle eş güçlü ve baskındır ve/veya kısa süreli evlilikler yaparlar. Bu erkekler annelerine yakındırlar.

Kadınlar(özellikle test 5 de yüksek ise) kendilerini güçsüz, aşağılanmış, suçlu ve çekingen olarak sunarlar. Bunlar gerçekte başkalarının kendilerini korumasını ve baskı altına almasını isterler. Bu tür ilişkiler sıklıkla suçluluk duygularının, genellikle ifade edilmeyen öfkenin bedelinin ödenmesi gibidir. Bireylerin öyküsünde çok çalışkan ve başarılı bir baba vardır.

Terapi prognozu sıklıkla iyi değildir, çünkü tedavideki kaygıya dayanma konusunda isteksizdirler. Katı, yönlendirici, amaç yönelimli terapi, belki de atılganlık eğitimini içeren tedavi düşünülmelidir.

Olası Tanı: Pasif-agresif kişilik bozukluğu
Depresif semptomlar
Anksiyete bozukluğu

248 Kodu

Depresyon, küskünlük, aile ve evlilik sorunları çok da olsa, bu tür bireyler 24/42 kod tiplerinden daha az açık kırgınlık biçiminde eyleme vurma davranışı gösterirler. Bunun yerine, kırgınlık içeren fanteziler kurarlar, başkalarına karşı kendilerini güvensiz, uzak ve bağları kopmuş gibi hissederler. Ancak dürtüleri üzerindeki kontrolü kaybetmekten korkarlar ve doğal olmayan, rahatsız edici düşünceler üzerinde çok fazla dururlar Sıklıkla başkaları tarafından huysuz ve nasıl davranacakları belli olmayan kişiler olarak görülürler.Çeşitli cinsel sorunlar, intihar düşünceleri ve çok sayıda intihar girişimleri vardır.

248 Kodu/Yüksek F Kodu

Temel şizofrenik konfigürasyon

25/52 Kodu

Bu koddaki erkekler, içe dönük, pasif, kararsız, depresif ancak idealist bireylerdir. Kaygılı ve geri çekilmişlerdir, somatik yakınma öyküsü verirler ve açık bir biçimde düşünememekten yakınabilirler. Nadiren flört ederler ve genellikle heteroseksüel uyumları göreceli olarak kötüdür. Sıklıkla bu kodda erkeklerde 7,3,4 ya da 0 alt testleri de birlikte yükselir.

25/52 koddaki kadınlar, depresiftirler ve kendilerine yönelmişlerdir, ancak başkalarına dayanmak yerine kendi kendilerine yetmeye çalışırlar.

Bu kodda ergenler, genellikle kardeşleri ya da arkadaşları ile ilişkilerinin kötü olması, utangaçlık, aşırı negativizm ya da aşırı duyarlık nedenleri ile başvururlar. Kişilerarası ilişkilerde utangaç, pasif ve çekingen olan bu ergenler sıklıkla mükemmeliyetçilik ve titizlikle birlikte aşırı entellektüalizasyon gösterirler. Genellikle kaygı, suçluluk, aşırı duyarlık, kendini suçlama, depresyon ve sosyal beceriksizlik vardır.

26/62 Kodu

Alıngan, depersif ve eleştiriye aşırı duyarlı kişilerdir. Bu bireylerde altta yatan güçlü bir kırgınlık duygusu ve sıklıkla süregelen kişiler arası ilişki güçlükleri vardır. Genellikle paranoid eğilim gösterirler. Nötr durumları kötü niyetli olarak değerlendirir ve yetersiz veriye dayanarak sonuç çıkarırlar Küskünlük, ajitasyon, yorgunluk ve saldırganlık genellikle belirgindir. Sıklıkla bu bireyler, başkaları onları reddetmeden önce onları reddetme düşüncesi ile ya da bağımlı olmaktan kaçınma aracı olarak kavgaya hazırdırlar. Pa alt testi belirgin bir biçimde yükseldiğinde ve/veya 4 ve 8 alt testi70T puanının üzerinde ise, bireyin psikozun erken dönemlerinde olma olasılığı artar. Bu tür hastalar, kırgın depresif kişilerdir. Çok şiddetli kırgınlıklarını çevrelerine ve kendilerine karşı yöneltebilirler. Kırgınlıklarını ifade edemeyen diğer deprese hastalara göre, bu hastalar açıkça hostile ve küskün olabilirler.

Olası Tanı: Psikozun erken dönemi

27/72 Kodu (Ayrıca 273/723, 247/724, erkekler için 275/725, kadınlar için 27/72 ve 278/728 kodlarına bakınız).

273/723 Kodları

Bu hastalar pasiftir, kişiler arası ilişkilerinde bağımlı olduklarında kendilerini çok rahat hissederler. Korunduklarında ve başkalarının bakımı altına alındıklarında bu duruma çok kolay uyum sağlarlar.

Bireyler, çoğunlukla kendileri için çok yüksek standartlar belirleyerek stres yaşarlar. Stresleri arttığında başkalarından yardım isterler, depresyon ve endişeleri içinde belirgin bir biçimde ve yapışırçasına bağımlı hale gelirler. Bu görünen çaresizlik, uysallık ve kendini değersizleştirme düşünceleri başkalarını, onları kurtarma ve korumaya yöneltir.

Hs alt testi de yükselmişse bu bireyler kaygıyla bağlantılı somatik yakınmaların yanı sıra, kendine acıma, suçlama ve başkalarının onlara bakmasını istemelerine karşın sosyal geri çekilme gösterirler.

274/724 Kodları (Eğer test 4 ve 7 birbirlerinin 5T puanı alanı içindeyse 247 ve 427 kod yorumlarına da bakınız.)

Yoğun yetersizlik ve suçluluk duyguları vardır. Kendilerini küçülterek, kendi zayıflık ve yetersizlikleriyle sürekli uğraşırlar. Diğer kişilere olan aşırı bağımlılıklarını kabul etmezler. Çoklu nevrotik belirtilerin gerçek bir düşünce bozukluğunu maskeleymesi ihtimali dikkatle incelenmelidir. İntihar düşünceleri, niyeti ve planı sıklıkla görülür. Bu açıdan değerlendirilmelidir. Hastaların olası klinik tanısı depresif reaksiyon olmakla birlikte, kişilik yapıları oldukça kalıcıdır. Temel anksiyetelerini ve davranış biçimlerini değiştirmek zordur.

Bu koddaki erkekler çoğunlukla annelerine bağımlıdır ve kendileri için de bağımlı ilişki ararlarsa da genellikle buna eşlik eden kontrolü istemez ve ilişkiyi sonlandırırlar. Alt test 3 yükseldiğinde kronik alkolizm olasılığı fazladır, alkol kaygıyı azaltmak ve depresyonla başa çıkmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu profildeki kadınlar sıklıkla babaları tarafından ilgi ve övünme nesnesi olmuşlardır. Genellikle, kendilerini izole ederler, zayıf ve çekingen görünmeye çalışırlar (özellikle alt test 5 düşükse) Diğerleri ile ilişkilerinde güçlükler yaşasalar da evli erkeklerle uzun süreli ilişkileri olabilir.

275/725 Kodları

Birey de endişe, depresyon ve aşırı düzeyde aynı şeyler üzerinde durmaya ek olarak, çekingenlik görülür. Kronik bir başarısızlık duygusu ya da kendilik değeri konusunda ambivalansları var gibidir. Kendilerini yetersiz, zayıf, aşağılanmış, suçlu ve pasif olarak tanımlarlar 4 alt testi düşük olduğunda daha belirgindir. Bireyler sürekli olarak başkalarının onları küçümsediği ilişkiler arayarak depresyonları için bedel öderler ve bu tür ilişkilerde çok rahat ederler. Karşı cinsle ilişkilerde güçlükler vardır.

278/728 Kodları

Gergin, kaygılı, depresif, aşırı biçimde aynı şeyler üstünde duran ve kendilerine ilişkin kuşkuyla dolu olan bu bireylerde intihar düşüncesi ya da giriřimi olasılıęı yüksektir. Obsesif düşünme, korkular ve fobiler çok görülür, bunların yanı sıra kendi başarısızlıkları üzerinde yoğunlaşırlar. Bu insanlar çoęunlukla çok titiz ve mükemmeliyetçidir, kendileri ve başkaları için çok yüksek standartlar koyarlar ve bu standartlara ulaşamadıklarında çok fazla suçluluk yaşarlar. Aşırı bir biçimde kendilerini sorgulamaları ve kendi kendilerine baskı yapmaları sıklıkla belirli bir şeye odaklanma güçlüklerine ve performansta düşmeye yol açar ve bu da onların depresyon ve kaygısını artırır. Karşı cinsle, aşk ilişkileri gibi duygusal bağlantılar kurmada özel zorlukları vardır. Sıklıkla bu tür ilişkilerin çok ufak ayrıntıları üzerinde odaklanır ve olması gerekenden daha fazla dikkat eder ve endişelenirler. Kontrol, eleřtiri, kabul edilme ve kızgınlığın ifadesi gibi durumlar sorun alanlarıdır.

Bu kodda, özellikle alt testlerden K ve Hs, 50 T puanının altında olduęunda ve/veya Ma alt testi yükseldiğinde intihar olasılıęı dikkatle deęerlendirilmelidir. Bu kodda Ma alt testinin yükselmesi, depresyonun ajite yönünü gösterir.Eęer Si alt testi yükselmiřse bireyin depresyonu daha çok kroniktir ve buna utangaçlık, içe çekilme ve fiziksel yetersizlik duyguları eşlik eder.Alt testlerden Pd düşük olduęunda pasiflik ve çekingenlik ön plandadır, sıklıkla cinsel ilgilerde azalma ve cinsel yetersizlik buna eşlik eder.

Kadınlarda 278/728 kodunda 5 alt testi düşmüşse bu kişiler, kendileri için bedel ödemeleri gerektiğini hissederler ve hatta bu şekilde başkalarının kızgınlığını arttırırlar. Bu kadınlar çoęunlukla mazohistik biçimde kendilerine kızarlar. Baş ağrıları, sırt ağrıları ve cinsel güçlükleri içeren çok çeřitli fiziksel yakınmaları vardır. Çoklu nevrotik semptomlar gösterirler.Majör semptomlardan depresyon, sinirlilik ve obsesyonlar görülür.Kararsızlık, şüphe ve kaygı karakterleridir.Obsesyonlarından dolayı düşünceye iyi kanalize olamazlar. Düşünce bozukluęunun deęerlendirilmesi önemlidir. Sosyal açıdan yetersizdirler. Aşırı obsesyonları için psikofarmakolojik tedavi gerekir. Psikoterapide daha çok problem çözücü ve destekleyici terapi tercih edilmelidir.

270 Kodu

Gergin, depresif, sinirli, kendini aşıęılayan, suçluluk duyguları olan kişilerdir. Devamlı aynı konu üzerinde düşünürler; yetersizlik, güvensizlik duyguları vardır. Aşırı kontrollü olmaya çalışırlar, duygularını açığa vurmada zorluk çekerler, kişiler arası ilişkilerde bağımlıdırlar, kendilerini ortaya koymaktan kaçınırlar.İçe dönük tutumları kronik düzeydedir. Şizoid kişilik bozukluęu tanısı konabilir.

28/82 Kodu (Uygunsa 281/821, 284/824 ve 287/827 kodlarına da bakınız.)

Bu kod tipindeki kişiler anksiyete ve ajitasyonla birlikte şiddetli depresyon yaşayan hastalardır. Depresyon ve ajitasyon, genellikle dikkat ve konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve konfüzyon hali ortaya çıkabilir. Sıklıkla obsesif ruminasyonlar sergilerler.Düşünce bozukluęu, yorgunluk gibi somatik yakınmalar sık görülür.Kişiler arası ilişkilerden ve aktivitelerden kendilerini izole edip çekilme eğilimleri vardır.İntihar giriřimleri olabilir.Dikkat edilmesi gerekir.Bu nedenle prognoz itibariyle hastanın deęiřmesi ihtimali zayıftır.Bu özelliklerin yanı sıra ‘şizofrenik özellikler’ de gösterebilirler.İřitsel ve görselel halüsinasyonlar ve sistemli hezeyanlar olabilir.Düşünce bozukluęu deęerlendirilmelidir.Garip

karakterde somatik semptomlar görülebilir. Deprese, izole ve çekiniktirler. Bu kronik uyum örüntüsü genellikle hastaneye yatmayla son bulur. **Bu hastalara en sık konulan tanı manik depresif psikoz, melankoli ve şizoaffektif bozukluktur.**

Özellikle ergenler başkaları ile duygusal bağlar kurmaktan korkarlar, duygusal bağımlılıkları ve cinsellik konusunda çatışmaları vardır. Sıklıkla çocukluk döneminde tekrarlanan incinme öyküsü anlatırlar. Karşı cinsle ilişkileri genellikle çok azdır, üstelik sorunlar yada sapkın davranışlar içerir. Ergenler duygularını uygun olmayan biçimlerde gösterirler, okuldan kaçarlar ve madde kötüye kullanım öyküleri vardır.

Bu bireylerde terapötik ilişki kurmak zordur, psikoterapi prognozu kötüdür. Psikofarmakoloji en azından başlangıçta yararlı olabilir.

281/821 Kodları

28/82 kodu ile bağlantılı genel özelliklere ek olarak, bu bireylerin çok çeşitli somatik yakınmaları vardır. Genellikle bunlar belirsiz ya da medikal yönden atıptır ve titremeler, düşünme güçlükleri ya da hatta somatik delüzyonlar içerebilir. Bu örüntü psikotik bir epizoddan önce gelen kendi üzerinde yoğunlaşmayı temsil ediyor olabilir ve genellikle açık bir gerginlik ve entelektüel konfüzyon ile bağlantılıdır. Diğer bireylerde, özellikle test 3 de yükselmişse, bu somatik yakınmalar ve bunlarla bağlantılı davranışlar, terapisti kurtarma davranışlarında bulunmaya teşvik edebilir, ancak birey bu yardımı reddeder.

284/824 Kodları

Yetişkinlerde bu kod sıklıkla şizoid ya da şizofrenik durumlarla bağlantılıdır ve F alt testi d yükselmiştir. 28/82'nin özelliklerine ek olarak kızgınlık, isyankarlık, başkalarından uzak ve soğuk olma duyguları güçlü bileşenlerdir. Dürtü kontrolünü kaybetme korkuları çoktur **(özellikle Pd alt testi 80'in üzerinde ise)** ve eyleme vuruk davranışlar, garip ve tuhaf şekillerde olur. Sosyal alanlarda ve evlilikte uyumsuzluk olasıdır (test 4, test 2 ya da 8'in 5T puanı alanı içinde ise 482/842 kodlarının yorumuna bakınız).

Ergenlerde bu kod, yetişkinlerde belirtilen devamlı bir patolojiyi temsil etmiyor olabilir. Bunun yerine, bu kod daha çok birçok ergende bulunan isyankarlığı ve sosyal gruptan uzaklaşmayı yansıtır. Dürtü kontrolünde zayıflık vardır ve bunun yanı sıra doğal olmayan davranışlar ve duygularda kısıtlılık görülür, ancak altta yatan patoloji daha az şiddetlidir.

287/827 Kodları

Bu koddaki bireyler depresyon, kaygı ve tanjansiyel düşünce süreçleri gösterirler, kendilerini insanlardan uzak hissederler, eleştiriye çok fazla duyarlıdır ve genelde insanlara güvenmezler. Bunlar çoğu zaman belirli bir şeye odaklanamama, dönmesi epizodları, mental konfüzyon, uykusuzluk, görev ve sorumlulukları yerine getirme yeteneğinin azalması gibi önemli mental güçlükler gösterirler. Ayrıca, değişken ya da uygunsuz duygular, hatta halüsinasyonlar ya da açık düşünce bozuklukları vardır. Tipik olarak bu bireyler, genellikle bağımlılık korkularına bağlı olarak yakın ilişkilerden kaçınırlar ve duygusal bağlanmadan korkarlar. Sıklıkla cinsellik ve kendini ifade etme konularında çatışmaları vardır. İntihar düşünceleri, zihnin sürekli bir şeyle meşgul olması ve tehditler çok olasıdır ve **eğer K alt testi 50 T puanının altında ise ve Ma alt testi 70 T puanının üzerinde ise** bunlar dikkatle değerlendirilmelidir. İntihar çoğunlukla garip biçimlerde gerçekleştirilir.

29/92 Kodu

Bu gruptaki kişiler benmerkezci ve narsisistik olma eğilimindedirler. Kendi değerlerini abartırlar. Bu bireyler yüksek bir enerji düzeyine sahiptir, ancak bu depresyon ve kaygı ile bağlantılıdır. Yüksek enerji düzeyi ya da başa çıkmayı ya da bir kontrol kaybını telafi etme girişimini temsil eder. Genellikle üç tip birey bu kodu elde eder:

Ajite depresyonu olan bireyler: Bireyde ağlama, feryat etme, depresif ruminasyonlar belirgindir. Çocuklar gibi ilgi çekmek için çok fazla duygusal olabilirler.

Altındaki depresyonlarıyla manik savunmalar kullanarak başa çıkmaya çalışan bireyler: Bazı bireylerde büyüklük düşünceleri ve inkar, depresyonu maskeleyebilir. Ancak çoğunlukla bu savunmalar uzun süre etkili değildir. Bireyde daha sonra çok fazla içki içme davranışı ortaya çıkar.

Organik beyin sendromu olan, işlevsellik ve yeteneklerindeki azalmanın farkında ama bunu inkar etmeye ve başkalarından saklamaya çalışan bireyler: Bu bireyler daha önce kolaylıkla yaptıkları şeyleri yapmanın eksikliğine bağlı ajitasyon göstereceklerdir.

20/02 Kodu

Bu bireylerde sinirlilik, zayıflık, yorgunluk, benlik değerinde düşme belirgin özelliklerdir. Kod sosyal olarak geri çekilmiş hafif, ancak kronik depresyonu olan bireyleri gösterir. Depresyon sıklıkla bireyin kişiler arası ve sosyal becerilerinin kötü olması ile bağlantılıdır ve aşağılık ve utangaçlık duyguları ile birliktedir. Profilde hem yetişkinler, hem de ergenler özellikle sosyal ilişkilerde sinirlidirler ve engellenmiş hissederler ve çok az arkadaşları vardır.Çoğu (**özellikle test 1 düşükse**) fiziksel olarak çekici olmadığını düşünür.Uykusuzluk, suçluluk duyguları ve endişe de sıklıkla vardır.

Olası Tanı: Pasif-agresif kişilik

207 Kodu

Bu kod tipindeki bireyler gergin, kaygılı, ürkek kişilerdir. Kendilik değerinde düşme vardır. Şizoid içe çekilme gösterirler. Sosyal ortamlarda yetersizlik duygusu ve gerçek sosyal beceri eksikliği ile içe dönük tutum sergilerler. İnsanlarla etkileşimlerinde güvensizdirler, karşı cinsle ilişkilerinde mutsuzdurlar. Depresyonları ile yaşamayı öğrenmişlerdir. Bu bireylerin saldırganlık ve öfke patlamaları göstermesi beklenmez.

3-(Hy) HİSTERİ

85 T PUANI VE ÜSTÜ: Aşırı immatür, benmerkezci ve bağımlı kişilerdir. Bastırma savunma mekanizmasını kullanmaları şaşırtıcıdır. Bu içgörü eksikliği olduğunun göstergesidir. Semptomlar gerçek organik patolojiye uymamaktadır. Genellikle kroniktir ve ciddi rijidite vardır.

76-85 T PUANI: T puanında bildirilen özelliklere ek olarak bu bireyler uzun süredir devam eden gerginliğe bağlı konversif semptomlar geliştirmişlerdir. Semptomlar baş ağrısı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, güçsüzlük, baş dönmesi ve baygınlıktır. Uzun süredir devam eden güven duymama, immatürite ve organize olmuş bedensel yakınmaları vardır.

70-75 T PUANI: Birey bastırma ve inkarı çok fazla kullanan, çok fazla itaat eden (uyan), saf ve çocuksu biçimde benmerkezci, anksiyete ile bağlantılı somatik yakınmaları olan ya da bunların hepsine sahip bir kişidir. Histeroid mekanizmaları kullanır ve bunlarla ikincil kazanç elde eder. Kişi, çok fazla sevgi, kabul ve destek isteyebilir, çok akif (yüzeysel olsa da) sosyal yaşamı vardır, ancak davranışları konusunda içgörüsü oldukça azdır. Bireylerden bazılarının, teşhirci ve seksüel ya da saldırganlık düzeyinde dışa vuran davranışları olabilir, inkar ve bastırmayı aşırı bir biçimde kullanırlar. Sevmeye olan güçlü gereksinime bağlı olarak, bağlanma gerektiren durumlarda verdikleri ilk tepki genellikle coşkulu olacaktır. Ancak, hemen ya da daha sonra, kendilerinden istenenler konusunda kızgın ve kinci olurlar ve genellikle pasif biçimde dirençlidirler, sızlanıp, yakınırırlar ve kendilerini bu durumdan uzaklaştıracak somatik şikayetleri olur.

60-69 T PUANI: Burada iki farklı örüntü vardır:

1-Eğer Hs'nin yükselmesi Hy ile aynı düzeyde ise ve D alt testi, 1 ve 3 alt testlerinden 10T puanı düşükse histerik kişiye işaret etmektedir. Stres sırasında somatizasyona sığınma görülebilir.

2-Eğer Hy alt testi Hs alt testinden 10T puanı yüksekse histerik özellikler belirgindir. Bu bireyler kendilerine odaklanmış, kendilerini olduğundan farklı ve mükemmel kişiler olarak görmek isterler. Kişilerarası ilişkilerde içgörü azlığı vardır.

45-59 T PUANI: Bu alana özgü bir tanımlama yoktur.

22-44 T PUANI: Kendilerini sürekli eleştirirler. Olumlu kişilerarası ilişkileri inkar etme eğilimi vardır. Si alt testinde yükselme, bireyin diğer insanlardan kaçma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Sadece Hy alt testinin yükselmesi: Sadece 3'ün yüksek olduğu ve diğer hiçbir alt testin 70 T puanının üstünde olmadığı durumda, bireyin kabul edilme ve sevmeye gereksinimi fazladır. Ait olduğu grup tarafından reddedilme olasılığına yönelik endişe yaşar, kızgınlık ve kendini ortaya koymayı içeren yüzleşme durumlarıyla (akademik ortamlar gibi) uğraşırken çok rahatsız olur. Tartışmalarda iyimserliklerini ve diğer insanlarla olan iyi ilişkilerini vurgularlar ve kendilerinde doğal olmayan ya da sapkın davranışları en aza indirgerler.

Hy KODLARI

Yüksek 3/Yüksek K Kodu

Alt testler ve K ikisi birden yüksek olduğunda ve F ve Sc alt testleri düşük olduğunda, sevilme, kabul edilme ve kendisini yaşamı üzerinde kontrol sağlıyor gibi gösterme gereksinimi çok abartılıdır. Karakter olarak, bu bireyler çok katı bir optimizm gösterirler ve bazı şeyler görünür biçimde felaket ya da başarısızlıkla çevrelenmişken bile bu iyimserliği

ısrarla sürdürürler. Bu insanların diğerleri ile iyi ilişkileri ve uyumları vardır ve kırgınlık, bozulma ya da zedeleyici duyguların olduğu ya da bağımsız karar vermeleri ya da güç kullanmaları gereken durumlardan kaçınırlar (ya da çok rahatsız olurlar).

31 Kodu(Bakınız 13/31 Kodu)

32 Kodu(Eğer 2 alt testi, 3 alt testinin 5 T puanı sınırları içinde ise 23 koduna da bakınız)

23 kod tiplerinin aksine, bu bireyler sağlıkları ve bir ölçüde belirgin olmayan depresyonları ile fazlaca ilgilenirler. Yorgunluk, gastrik yakınmalar, baş ağrıları ve baş dönmesi geneldir, ancak çeşitli fiziksel yakınmalar da olabilir. Genellikle bu semptomlar hafiftir ve anksiyete ve depresyon duygularını kontrol etmeyle açık olarak ilişkilidir.

Erkekler, anksiyeteye ilişkin olarak genellikle gergin ve meraklıdır, iş sorunları ile kendilerini üzerler, gerginliğin sonucu semptomlar ortaya çıkarlar. Bedensel sorunlarının psikolojik yorumlarını reddederler ve içgörülerini yoktur. Semptomları konusunda açıklama yapılması yararlı olur, sürekli psikolojik yardım alma olasılıkları düşüktür. Erkekler için test 1,8 ve 9 sıklıkla üçüncü en yüksek testtir.

32 kodlu kadınların sıklıkla sorunlu evlilik öyküsü(boşanmalar nadiren olsa da) vardır, kocaları ile cinsel ilişkiyi istemezler ve cinsellikten hoşlanmadıklarını belirtirler. Tipik olarak depresiftirler, eşlerinin sadakatsizliğinden ve alkol almasından yakınır. Eleştiriye ve reddedilmeye karşı aşırı duyarlıdır ve bu kadınların çoğu kronik mutsuzluğa dayanabilirler. Genelde, kendilerini yetersiz hissederler ve önemli ölçüde kendi kendilerine ilişkin kuşkuları vardır. Yorgunluk ve tükenmişlikten yakınabilirler, (özellikle eğer test 5 düşükse) ancak işlerinde çalışkan olma eğilimi gösterirler. Çarpıntı, terleme, uykusuzluk ve belirsiz korku gibi fiziksel semptomlar sıklıkla bildirilir. Bazen bu profil menopoz güçlükleri ile bağlantılıdır.

Bireylerin kendileri ya da başkaları hakkında fikirleri yoktur ve bunun bir sonucu olarak sıklıkla kendilerini rahatsız edici kişiler arası ilişkilerin içinde bulurlar. Engelleyici durumlar karşısında kendini cezalandırıcı biçimde depresif olma ya da kendilerine zarar verecek biçimlerde tepki gösterme eğilimindedirler. Örneğin, sıklıkla başkalarının eleştiri ya da reddetmesini teşvik edecek biçimde aşırı tepki gösterirler. Karışık nevrotik bir semptomatoloji ile eşleşen kronik nevrotik bir durumu ortaya koyan bu hastalarda depresyon, çökkünlük, gerilim, kaygı ile birlikte özellikle baş ağrısı ve uykusuzluğun eşlik ettiği çoklu somatik yakınmaları vardır. Özellikle histerik davranışları ile ikincil kazançları gözlenebilir. Tedavi motivasyonları düşüktür. Yetersizlik duyguları, genellikle kronik nevrotik bir durum sergiler.

34/43 Kodu

Her iki kod tipi de kırgın, immatür ve bencildir. Evlilik uyumsuzluğu, rastgele cinsel ve yüzeysel ilişkiler, boşanma, alkolizm temel özelliklerdir. En belirgin özellikleri kronik ve şiddetli öfkedir. Düşmanlık ve saldırganlık dürtüleri vardır. Öfkelerini olduğu gibi gösterirler ve bu duygularını uygun zamanda ifade edebilecek uygun yolları geliştirememişlerdir. Çoğunlukla aşırı kontrollü olmalarına karşın kısa saldırganlık dönemleri vardır. Başkalarını cezalandırma ve sorunları için başkalarını suçlama eğilimi içindedirler. Sıklıkla kişilik bozukluğu tanısı konulmaktadır. Ancak 3 ve 4'ün göreceli yükseklikleri bu tür bireylerin kırgınlıklarını ve diğer impulslarını ne ölçüde keşlediğinin

(eğer 3 yüksekse), ya da öfkelerinin daha fazla ifade edildiğinin **(eğer 4 yüksekse)** bir göstergesidir.

Koddaki kadınlar sıklıkla yaşamlarının yüzeysel yönleri üzerinde çok fazla dururlar, sabırsızdırlar ve sürekli isterler. Ayrıca hafif düzeyde psikosomatik yakınmaları vardır.

34/43 kodu ebeveynleri, okulla ve otoriteyle çatışması olan ergenlerde çok sık ve görülür. Hırsızlık, ilaç kullanımı, okuldan kaçma ve evden kaçma sıklıkla vardır, ayrıca intihar düşünceleri ve uyku güçlükleri gözlenir.

Olası Tanı: Pasif agresif kişilik bozukluğu, agresif tip

Yüksek 3/Düşük 4 Kodu

Alt test 3'ün önemli ölçüde yüksek olduğu durumda, birey kızgınlık duygularını dolaylı olarak gösterir ya da dışavuran davranışları olan bireylerle birlikte kızgınlık ve isyan duygularını ifade eder.

Sıklıkla bu bireyler, bağımlılık bağımsızlık çatışması yaşarlar. Kızgın bir biçimde çok fazla istenmek ve yeterli derecede istenmemek arasında gider gelirler. Bağımlı olmak istemelerine karşın, burada kendi rollerinin ne olduğu konusunda içgörülerini yoktur. Bastırma, inkar ve kızgınlığın aşırı kontrol edilmesinden dolayı, öfke patlamaları olduğunda tipik olarak aşırı öfkeli olurlar, ancak hemen bunu iyi bir biçimde rasyonalize ederler.

34 kodunda, 4'ün 3'den önemli ölçüde yüksek olduğu durumlarda, kızgınlık baskındır, ancak uzun süre baskı altında tutulmuştur ve sonra öfke patlamalarıyla ifade edilir, hatta bazen ciddi saldırı ya da cinayetlerle sonlanır. Bu bireylerin çoğu, uzun zaman sessiz ya da hatta geri çekilmiş görünürler ve bunların patlamaları çok şaşırtıcı olur, çünkü öfkeyi başlatan sıklıkla çok küçük bir olaydır. Bazen bu bireylerde şiddet patlamaları döngüsel bir örüntüde olur.

Kadınlarla yapılan bir araştırmada arkadaşları bu kadınların sabırsız olduklarını belirtirken kadınlar kendileri konuşkan, enerji dolu, tam anlaşılmayan kişiler olarak tanımlamaktadır. 3'te bastırma, 4'te saldırganlık fazladır, 3 yüksek 4 oldukça yüksek ise pasif-agresif kişiliktir. Sinsi tipler ufak bir hadise çıkarıp önemli bir şeyi engellerler.

345/435/534 Kodları

Bu profildeki erkekler, diğerleriyle olan ilişkilerinde belirgin bir biçimde immatür ve genellikle cinsel yönden yetersizdirler. Sıklıkla sıradan cinsel ilişkiden farklı bir ilişki ararlar, teşhircilik görülebilir, homoseksüel olma korkuları vardır. Alt test 3, 4'ten yüksekse ve K alt testi 50 T puanının üstündeyse, duyguların ve isteklerin eyleme dökülme olasılığı düşüktür.

346/436 Kodları (Eğer 6 alt testi, 3 alt testinden 5T puanı sınırları içinde ise, 36/63 kodlarına bakınız.)

Sıklıkla bu bireyler uyumlu gibi görünseler de, dönemsel aşırı eyleme vuruk davranış öyküleri olabilir ve bunu uzun süre devam eden sıradan davranışlar izler. Sıklıkla bu bireyler eleştiriye aşırı duyarlıdır ve kızgınlık duygularının bir sonucu olarak gergin ve kaygılıdırlar. Genellikle bunların kızgınlıkları aile üyelerine yöneliktir, ancak zihinlerinde bu durumu iyi bir şekilde

rasyonalize eder ve kendilerini haklı çıkarırlar.Çoğu, eyleme vuruk davranışları olan bireylerle uzun-süreli (ancak sıklıkla çalkantılı) ilişkiler kurarlar, böylece kendi kızgınlık ve isyankar impulslarına başkaları aracılığıyla doyum sağlarlar.Onların düşünceleri genellikle diğerlerini suçlamaya yöneliktir ve bu bireyler nadiren değişme gereksinimi duyarlar ve psikolojik tedaviyi reddederler.

35/53 Kodu

Bu koddaki erkekler pasif ve hatta geri çekilme eğilimindedirler.Davranımda bulunmaktan çok beklerler, inhibe ve güvensiz görünürler, ancak çok güçlü ilgi gereksinimleri vardır.Genellikle utangaç, kaygılı ve sosyal olarak rahatsızdırlar(**özellikle eğer Si alt testi yükselmişse**).Çoğunun ahlak anlayışı farklıdır.

36/63 Kodu

Yüzeyde, bu bireyler eleştiriye aşırı duyarlı, kuşkulu, gergin ve hatta şüphecidirler.Sıklıkla baş ağrıları ya da gastrointestinal yakınmaları da vardır.Sorunlar ortaya çıktığında başkalarını ya da durumları suçlarlar.Yüzeydeki bu durumun altında, aile üyelerine karşı yaygın ve uzun süredir devam eden kızgınlık duyguları vardır.Kızgınlık fark edildiğinde rasyonalize edilir.Bu hastalar eleştiriye aşırı duyarlıdır, belirgin anksiyete ve gerginlikleri vardır.Sıklıkla somatik yakınmaları getirirler.Gerçekte bu bireylerin çoğu ile birlikte olmak zordur, çünkü kendileri üzerinde odaklanırlar ve vücut pozisyonları sanki tetikte gibidir.Bu ikili kod kadınlar arasında erkeklere oranla daha fazladır.

Alt test 6, 3'ten 5 ya da daha fazla T puanı yüksek olduğunda, bu birey güç ve prestij kazanmak ister ve kızgın bir biçimde bencildir, hatta bu acımasız manipülasyonlar noktasına gidebilir.Tipik olarak bu bireyler davranışlarında katı ve savunucudurlar.Bazıları belirgin paranoid özellikler gösterebilir.

Alt test 3, 6'dan yüksekse, bu tür bireyler kızgınlıklarının farkında değildirler, ancak bu başkaları için çok açık olabilir(Başkaları bunu açık bir biçimde fark edebilir). Kendi üzerinde odaklanma ve ben-merkezcilik açıkça vardır ve genellikle incitme duyguları birliktedir. Bu kod tipi 34 kod tipine de benzemektedir. Kızgın, hostile kişilerdir. Bu özelliklerini ve şüphe duygularını inkar ederler. İlişkilerini genellikle olumlu algırlar. Gerçek durumun böyle olmadığını da anlamakta güçlük çekmektedirler.

37/73 Kodu

Çok sık rastlanamayan bir koddur; gerginlik, anksiyete, uykusuzluk, kronik rahatsızlık, diğer bedensel yakınmalar ve düşük akademik başarı ile bağlantılıdır. Bu semptomların altında çözümlenmemiş bağımlılık istekleri, yetersizlik duyguları yatmaktadır. Ancak bu bireyler bastırmayı kullanırlar ve bu içgörüyü önemli ölçüde engel olur. Birey düşünce ve davranışlarında tuhaf ve gariptir ve belirli bir şeye odaklanmada, hatırlamada ve hatta karar vermede güçlükleri vardır. Kendilerini yabancılaşmış hissetseler de abartılmış bir sevilme gereksinimi duyarlar, ancak başlanmaktan korkarlar. Başkalarından sevgi almaya çalıştıklarında tipik olarak bunu çocuksu bir biçimde yaparlar ve başkaları bunu tuhaf bulur.

Bunların psikolojik karmaşaları oldukça büyüktür, öyle ki bu durum otistik aşırı düşünme ya da delüzyonlar gibi majör bir düşünce bozukluğunu temsil ediyor olabilir, buna davranışsal regresyon eşlik eder. Gerçek olmama duyguları ve duygusal uygunsuzluğa, bulanık görme,

baş dönmesi, ateş basması ve baş ağrıları eşlik eder. Bazıları kısa, cinsellikle dolu psikotik epizodlar gösterirler ve bunu daha sonra hatırlamazlar. Gergin, kaygılı kişilerdir. Psikolojik stres ya da çatışmalar sonucunda kronik fiziksel yakınmalar geliştirirler. Dışarıdan görülen davranışsal gerginlik ve kaygıya rağmen psikolojik sorunlarının varlığını inkar ederler.

38/83 Kodu

Bu hastalar ruhsal karmaşa içindedirler. Düşünme ve konsantrasyon bozukluklarından yakınır. Psikolojik stres, fiziksel streslerle ifade edilir. Fiziksel yakınmalar; baş ağrısı, uykusuzluk ya da yorgunluk olabilir, bizar özellikleri vardır. İmmatür, egosantrik ve bağımlılık gibi histerik özelliklerin yanı sıra hostilite, gerginlik ve endişe sergilerler. Gerçek psikotik olabilirler. Bir düşünce bozukluğu ihtimali dikkatle değerlendirilmelidir. Psikotik reaksiyonlar görüldüğünde bunlar davranışsal regresyona eşlik eden infantil venarsistik niteliklerdir. Çağrışımlarda bozukluk görülebilir. Obsesif düşüncelere, açık delüzyona, halüsinasyonlara, anlamsız ve enkoheran konuşmaya rastlanabilir. Destekleyici yöntemler telkin edilmelidir.

Olası Tanı: Şizofreni

Bazı durumlarda histerik nevroz

39/93 Kodu

Bu bireyler genellikle girişken, dışadönük ve açık olarak kendine güvenen kişilerdir, ancak çok yüzeysel olabilirler (**özellikle eğer alt test Si 40 T puanının altında ise**). Genellikle sözel olarak saldırganlıklar, bağımlılık-bağımsızlık çatışmaları vardır ve özellikle baskıcı anneye karşı kızgın olarak tanımlanırlar. Klinik ortamlarda dönemsel anksiyete ve akut rahatsızlık öyküleri vardır ve sıklıkla bunlara çarpıntı, taşikardi ve gastrointestinal alanla ilgili semptomlar eşlik eder. Genelde bu semptomlar medikal yönden doğal ve olası değildir. Tipik olarak bireylerdeki bu somatik yakınmalar, güvenceyle birlikte verilen semptomatik tedaviye iyi yanıt verirler.

30/03 Kodu

Nadir görülen bu kod pasif, bağımlı ve geri çekilme boyutunda sosyal yönden pasif olan bireylerle bağlantılıdır. Ancak, onlar bu tür bir uyumda göreceli olarak rahat görünürler ve sosyal durumlardan kaçmayı ve rahatsız edici duygularını bastırmayı yeğlerler. Stres durumlarında dönemsel psikosomatik yakınmalar görülebilir.

4-(Pd) PSİKOPATİK SAPMA

80T PUANI VE ÜSTÜ: (70-79 T puanında verilen özelliklere ek olarak) bu yükselme klinik tanı olarak psikopatik bir bireyi göstermektedir. Antisosyal davranışlar, otorite figürleri ile çatışma vardır. Diğerleriyle kendi gereksinimlerini nasıl karşılayabileceklerine bakarak ilişki kurar.

70-79 T PUANI:Bu alt testte yüksek puan alan bireyler, öfkeli, impulsif, duygusal açıdan yüzeysel, yordanamaz davranışları olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.Bu tür kişiler, sosyal uyumsuzluk, otoriteye ve diğerlerine karşı olma davranışları gösterirler.Alt test 4'teki yükselme, antisosyal tutum,ve davranış eğilimlerine işaret eder, ancak bu her zaman açık davranış biçiminde ifade edileceği anlamına gelmez.Antisosyal davranışlar, açıkça gösteriliyorsa özellikle alt test 9'la birlikte yükselme görülür.Yüksek puan verenlerin kendilerine ilişkin mükemmeliyetçi ve narsistik kavramları vardır ve bu kişisel standartları, sosyal kuralları reddetme rasyonalize etmede kullanılmaktadır.Bunların kızgınlığı ailelerine ya da genellikle otorite ve topluma karşı ya da her ikisine karşı olabilir.Bazen kızgınlık durumsal bir tepki(boşanma vb.) ya da ergenlik isyanı olabilir ya da bir kültürel azınlık grubunda olmayla bağlantılılığı yansıtabilir.Böyle olmadığında örüntü uzun sürelidir ve değişme olasılığı düşüktür.Ancak bireylerin küskünlük ve sosyal olmayan impulsleri ele alma biçimleri büyük ölçüde farklılık gösterebilir. İmpulsif olma, kişilerarası ilişkileri değerlendirmede bozukluk, davranışların önceden kestirilememesi, sosyal yabancılaşma, azalmış sorumluluk ve ahlak duygusu ve buna eşlik eden kötü iş yaşamı ve evlilik uyumsuzluğu vardır.Uzun vadeli hedeflerini kısa süreli arzuları uğruna feda ederler ve sonuçları tahmin etme kapasiteleri sınırlıdır.

Ergenler için yüksek Pd profilleri; Bunlar karakteristik olarak evden uzaklaşmak ve kendi kimlik duygularını oluşturmak için isyan ederler.**Ancak 25 yaşın üzerindeyse** bu yükseklik doğal değildir.**40 yaşın üstünde yüksekse;** uzun süren kişilerarası ilişki kuramama ve antisosyal davranışları yansıtırken, **60 yaş üzerinde,** apatik bir biçimde katılmama düzeyine varan yabancılaşmayı düşündürür.Bu tür bir kızgınlığı başlatan yaşam olayı olmadığında, test 4 özellikleri kalıcı ve değişime dirençlidir.

60-69 T PUANI: Risk alabilen, enerjik, sosyal, maceraperest ve atılgan olan bir bireyle bağlantılıdır. Ancak, bu bireyler engellendiklerinde bu özellikler huzursuzluk, saldırganlık ve sosyal olarak uyumlu olmayan davranış biçimine dönüşebilir.

45-59 T PUANI:Aşırı kontrol koyma ve kısıtlanma genellikle azdır.Sosyal kurallara kısmen uyum vardır.

20-44 T PUANI:Durağan, pasif ve atılgan olmayan bireylerdir.Maceraperest değildirler ve sıklıkla sosyal geleneklere uyma konusunda bağımlı ve hatta katıdırlar.Danışma durumunda başkalarının onlara karşı olan düşünceleri konusunda güvence ararlar.Çok sevgi dolu olsalar da, sıklıkla cinsel ilişkiye girme konusunda girişken değildirler.

Sadece Pd alt testinin yükselmesi:Pd alt testinin diğer testlerden en az 10 ya da daha fazla T puanı yukarıda olmasıdır.Bunlar, impulsif, küskün,isyankar,ve genelde kurallar, düzenlemeler ve otoriteyi kabullenmekte güçlükleri olan bireylerdir.Sıklıkla yasal sorunları olabilir.İnsan canlısı olabilirler(**eğer test 0 düşükse**), ancak diğerleriyle ilişkileri , yüzeysel, yapay ve kısadır.Uzun süren, yakın ilişkiler kuramazlar, çünkü birliktelikle ilgili empati, sorumluluklar ve talepler konusunda güçlükleri olan bireylerdir.Uzun süreli hedeflere doğru organize davranışları sürdüremezler ve bunun yerine doyum veren kısa süreli istekler üzerinde odaklanma eğiliminde olurlar.**Alt testi Si 30 T puanına yaklaşırsa,** bu sorunlar daha kalıcı ve şiddetlidir, ancak birey hoş ve rahat görüntüsü verebilir.

Pd KODLARI

41/14 Kodu(Bakınız 14/41 Kodu)
42/24 Kodu(Bakınız 24/42 Kodu)
43/34 Kodu(Bakınız 43/34 Kodu)

Yüksek 4/Düşük 5 Kodu (Ayrıca Mf alt testinin düşüklüğüne de bakınız)

Erkeklerde düşük 5, bireyin kendini erkeksi, hatta aşırı erkeksi gösterme çabasını yansıtır.Kaba ve geleneksel maskülen ilgileri olanlar da, bu grubun geleneksel değerlerini yansıtabilir.Orta ya da üst sınıftan ve yükseköğretim eğitimi olan erkeklerde bu örüntü, yetersizlik duygularını, özellikle kadınlara karşı, güçlü bir biçimde kapatma çabasını düşündürür.Sıklıkla kendi egolarını desteklemek ve kendi kendilerine güç ve kontrolü kanıtlamak için kadınları aşağılarlar.

Ergenlerde bu örüntü, açık suçluluk ile bağlantılıdır.

Bu örüntüdeki kadınlar kızgındır, ancak bu duygularını doğrudan ifade edemezler.Bunların kızgınlığı özel olarak erkeklere yöneliktir ve heteroseksüel sorunlar beklenir.İlginç olarak bu kadınlar, ilişkilerinde yüzeyseldir ve sıklıkla çekingen, yumuşak başlı ve çekici biçimindeki kültürel kadın stereotipleri ile özdeşleşmişlerdir ve bu tür rolleri aşırı sevgi ve ilgi gereksinimlerine doyum sağlamak için oynamaya çalışırlar.Genellikle aşırı talepkar ve bağımlıdırlar.Erkeklerle karşı olan kızgınlıklarını pasif-agresif biçimde cinsel yolları kullanarak ifade ederler.Kadınlar sıklıkla bu tür davranışlarla (özellikle eğer test 6'da yüksekse) başkalarını da kızdırmaya çalışırlar, ancak sonra yanlış anlaşıldıkları için kendilerine acırlar.Hatta bir melodram krizi başlatmış oldukları için hoşlanmış görünürler.Alt test 3 de yükselmişse, bu kadınlar kendilerinin başkaları üzerindeki etkisinin farkında değildirler ve düşmanlık duygularını inkar ederler. Evlilik ve aile sorunları ve cinsel fonksiyon bozuklukları ve cinsel hoşlanma eksikliğinin olması şaşırtıcı değildir.Baş ve sırt ağrıları da sık görülür

45/54 Kodu

Ergenler için bu kod, öfke patlamalarının olduğunu gösterir.Kuralları ve otoriteyi sevmeyen ve sıklıkla okuldan kaçma, okula ara verme ve sınıfta kalma öyküleri vardır.Özellikle 4 alt testi, 5 alt testinden daha yüksek olduğunda bu daha belirgindir.Bireyler öfkelerini kontrol etmede büyük zorluk çekerler.İlaç kullanımı, hırsızlık veya anti-sosyal davranışlar da olabilir.Ancak bu ergenler girişken(insan canlısı), dışa dönük ve genellikle akranları tarafından sevilen kişilerdir ve prognoz iyidir.

Bu koddaki yetişkinler, liseden daha az eğitimi olan kişilerdir ve sıklıkla olgunlaşmamış ve narsisistiktir.Görünüşleri ve davranışları ile sosyal kurallara meydan okumaktan zevk duyarlar.Bu tür uyumsuzluklarından zevk alıyor gibidirler.

Lise ya da daha yüksek eğitimi olan yetişkin erkeklerin narsistik biçimde uyumsuz olma olasılığı daha azdır, bunun yerine bu bireyler kurumlara karşı sosyal protestolar yada hareketler içine girerler.Sıklıkla bu erkekler, çok idealist ve fikirlerini açık ve etkin bir biçimde iletebilecek yetenektedirler.Baskın olma ve bağımsızlık bu bireyler için önemli konulardır.Uyumsuz davranışları, kendi kendilerine bağımsız ve yeterli olduklarını göstermek

için yaparlarsa da bağımlı olmayı arzu ederler.**Alt test 3'ün sonraki en yüksek test olduğu durumda**, birey aşırı kontrollüdür ve bağımlılık ve hatta pasifliği daha fazla vurguluyordur.

45 ve 54 kodlu kadınlar tipik olarak bu bireyler pasifliği, kadınsı rol ve kendilikle birleştirirler.Bu kadınların bazıları için, bu erkeksi bir protesto ve/veya lezbiyen bir ilişkide erkek rolünün kabul edilmesidir.Diğer kadınlarda, özellikle kırsal alan kadınlarında bu profil sadece geleneksel olarak kadınsı olmayan bir yaşam biçimini gösterir ve atılganlığı gerektiren kendi alt kültürlerinin pratik, mekanik işleriyle uğraşırlar.

Olası Tanı: Pasif agresif kişilik bozukluğu, pasif tip
Erkeklerde 5 yüksektir.
Kadınlarda 5 düşüktür.

456 Kodu

Talep edici, bağımlı ve duygusal kişilerdir, ancak diğer kişileri tedirgin ederek ve onlara karşı çıkarak ilişki kurarlar.Davranış örüntüleri yakın aile çevrelerine yabancılaşmalarına yol açar.Bu durum talep edici, bağımlı ve duygusal ilişki gereksinimlerini karşılamalarını güçleştirir.

46/64 Kodu

Temel özellikler kırgınlık, küskünlük, güvensizlik, somurtkanlık, sinirlilik, eleştiriye ve başkalarının isteklerine karşı aşırı duyarlılık ve suçun başkaları üzerine yansıtılmasıdır.Bu bireyler kendilerini çok çabuk reddedilmiş hissederler, yetersiz veri ve çok az öngörü ile sonuçlara varırlar.Düşünceleri, tipik olarak nasıl ihmal edildikleri, başkalarının nasıl hatalı olduğu ve kendilerini nasıl koruyabilecekleri üzerinde odaklanır.Zor durumlar ya da sorunları yaratmada kendi rollerinin ne olduğu üzerinde düşünmezler.Bu bireylerin öyküleri, ciddi sosyal ilişki sorunları, çok az yakın ilişkiler ve sıklıkla ilaç kullanımı ya da alkolizm gösterir.

Başkalarının kendiyile çok fazla ilgilenmesini isterler, ancak aynı davranış kendilerinden beklenildiğinde gücenip kızarlar.

Bu kod, yetişkin normaller arasında nadirdir, ancak ergenlik dönemine özgüdür.Bu koddaki ergenlerin aileleriyle ve otorite figürleriyle sürekli çatışmaları vardır; onları kinci, düşman ve yalancı oarak görürler.İmpulsların kendine zarar verici biçimde kontrol edilmemesi karakteristiktir ve buna yeterli öngörü ya da düşünme olmaksızın davranışa dökme eşlik eder.İsyankarlık, itaatsizlik, negativizmve tartışma geneldir.Sıklıkla bunlar diğerlerini açık bir biçimde kışkırtırlar, ancak davranışlarının sorumluluğunu taşımazlar.

Yetişkin erkeklerde bu kod sıklıkla psikotik ya da pre-psikotik durumlar ile(bakınız 468/648 kodları) ya da borderline kişiliklerle (bakınız 462/642 ve 463/643) bağlantılıdır.Bireylerin hepsinde kuşkuculuk, güvensizlikve aşırı genelleme ile paranoid özellikler vardır.Alt test 4, test 6'dan yüksek olduğunda, aile ve iş güçlükleri tipiktir, bunlarla birlikte kırgınlık hakim özelliktir.Alt test 6, 4'ten yüksek olduğunda aile ve iş güçlükleri tipiktir, bunlarla birlikte kırgınlık hakim özelliktir.Alt test 6 4'ten yüksek olduğunda daha çarpıcı paranoid özellikler ön plandadır.Bu erkekler, kırgınlıklarını genellikle kontrol ederler, ancak etrafındakileri şaşırtacak şekilde dönemsel patlamalar gösterebilirler.

Kadınlarda 46/64 kodu psikoz ya da prepsikozla(**özellikle eğer test 8 yüksek ve K düşük ise**) ilişkili olabilir, ancak sıklıkla pasif-agresif kişilik biçimleri ile özellikle erkelere kızgınlıkla bağlantılıdır.(**Bakınız yüksek 4, düşük 5**)

Olası Tanı: Pasif-agresif kişilik bozukluğu

Eğer 8 alt testi yükselmişse, borderline ya da psikotik bozukluk tanısı konabilir.Hasta çok savunucu ve projektif testler verilebilir.

462/642 Kodları

46/64 koduyla bağlantılı kızgınlık ve duyarlılığa ek olarak, bu bireyler ajitedirler.Sinirlilik, kaygı ve depresyon yakınmaları vardır.Sıklıkla bu manipülatif bir ilgi, sempati ve kontrol isteğidir.İntihar tehditleri görülür.

Bu bireyler başkalarına karşı güvensiz ve kuşkucudurlar ve onlardan şüphelenirler.Özellikle küskündürler ve otorite durumundaki bireylerle sorunları vardır, sıklıkla sorunlarının suçunu bu otorite figürlerine yansıtırlar.Yaşadıkları sorunları, kendi kontrolleri dışındaki konulara bağlayarak ya da başkalarını suçlayarak rasyonalize ederler.Cinsellikte ve evlilikte uyumsuz olabilir.

Genelde insanlarla olan rahatsızlıklarına ve otoriteye olan kızgınlıklarına karşın, bireyin abartılmış bir sevgi ve bağımlılık gereksinimleri vardır.Bunların rahatsızlık ve eleştirilerinin çoğu aşırı biçimde diğerlerine bağımlı olma korkularından (ve böylece başkaları tarafından kontrol edilme)kaynaklanıyor görünmektedir.Sonuç olarak, aileleri ya da çalışma arkadaşları ile azalmış bir birliktelik duygusu gösterebilirler.

463/643 Kodları

Bu bireylerin aşırı sevgi isteklerinin doyurulması, özellikle bu bireylerin gereksinimleri karşılanmadığında gösterdikleri olumsuz duygulardan dolayı zordur.Genellikle bağımlılık gereksinimleri heteroseksüeldir ve benmerkezci biçimlerde isteme(hatta düşmancıl) şeklinde ifade edilir, bazen açık manipülasyon ya da kışkırtma içerir.Bu örüntü, sıklıkla kendi kendini bozguna uğraticıdır, ancak bunların eşleri bireyin aşırı ister durumundan bıktıklarında onlara gereken ilgiyi göstermezler.Sıklıkla benzer biçimde terapist ya da tedaviyi veren diğer bireylerden de aşırı isteklerde bulunurlar, ancak aynı zamanda da aldıkları tedaviyi eleştirir ve karşı çıkarlar.Reddedilmeye olan duyarlılıkları ile, bu kod tipindeki bireyler kronik olarak acı çeken, küskün ve güvensiz kişilerdir.İçgörülerі yoktur.5 alt testinin 40 T puanının altında olduğu kadınlarda pasiflik, bağımlılık ve kendine acıma görülür.Menstrasyonda düzensizlikler, cinsel işlev bozukluğu, baş ağrıları ve sırt ağrıları gibi fiziksel yakınmalar da olur.

468/648 Kodları

Eğer birey psikiyatride yatan bir hasta ise şiddetli ve olasılıkla kronik, duygusal bir rahatsızlığı, büyük olasılıkla paranoid şizofreniyi düşündürür.Bu bireyler kuşkucu, kızgın, aşırı duyarlı, suçlayıcıdır.Eleştirden kolayca yaralanırlar ve durumlara kötü niyetli anlamlar yükleme ve düşüncelerinde aşırı genelleme eğilimindedirler.Kendilerine yapılan gerçek ya da hayali haksızlıklar üzerinde kızgın bir biçimde sürekli düşünme eğilimindedirler, delüzyonlar ya da referans fikirleir olabilir, büyüklük (grandiozite)elemanları, en azından benmerkezci tarzda olabilir.Bireyler gerçekte kızgınlıklarını(ve diğer psikolojik problemleri) inkar ederler ve kızgınlığı başkalarına yüklerler, bunu sıklıkla, yansıtmayı şeffaf bir biçimde

kullanarak yaparlar.Kızgınlıklarını fark ettiklerinde, bunu kafalarında iyi bir şekilde rasyonalize eder ve kendilerini haklı çıkarırlar.

Kızgınlığa sıklıkla yargılamanın kötü olması, içgörü eksikliği ve impülsivite eşlik eder.Saldırı, ilaç kötü kullanımı ya da bağımlılığı ve intihar girişimlerinin hepsi olabilir.Kişiler arası evlilik ve cinsel uyum sorunları tipiktir.

K testi 50 T puanının altında, test 5,4 ve 6'nın 5T puanı alanı içinde ve/veya alt test 9 ve 2 de 70 T puanının üzerinde olduğu durumlarda impuls kontrolünde azalma vardır.

469 Kodu

Bu ani öfke patlamaları olan bireyleri göstermektedir.

47/74 Kodu (Ayrıca 247/427/274 kodlarına bakınız.)

Bu bireylerde (hem ergenler, hem yetişkinler)kızgınlık açıkça göze çarpan bir özellik ise de, kendi kendini eleştirme ve suçluluk da sık görülür.Bireyin davranışı döngüsel bir örüntü gösterir.Bir dönem için düşünmeden ya da çok az impuls kontrolü ile narsisistik ve kendi isteklerini önplana çıkarıcı bir biçimde eyleme vuruk davranış gösterirler.Bu sırada, sıklıkla başkalarının isteklerini, duygularını düşüncesizce ayaklar altına alır, sosyal ve yasal sınırlamaları çiğnerler.Eyleme vurma döneminden sonra (bu sıklıkla rastgele cinsel ilişkiler, fahişelik ya da aşırı alkol kullanımını içerir), davranışlarının sonucundan dolayı çok fazla pişmanlık, utanma ve suçluluk yaşarlar.Vicdan azapları çok şiddetli olursa da, davranışlarını kontrol etme (genellikle aşırı kontrol etme eğilimi) geçicidir ve daha sonra da eyleme vuruk davranış dönemleri beklenir.

Davranışlarının altında, bağımlılık ve bağımsızlık arasında büyük çatışma vardır. Görünen davranışsal sosyal aldırmazlıklara karşın, güvensizdirler, güçlü ilgi ve güven gereksinimleri duyarlar.Özellikle kendilerinin aşırı düzeyde kısıtlandığını ya da değerlerinin bilinmediğini hissederler, ev çatışmaları ile ilgili olarak sürekli bir küskünlük gösterirler.Bunların dışı vurumu, bağımsızlığın immatür bir ifadesi olabilir.Başkaları tarafından konulan kurallar ve düzenlemeleri çok fazla sinir bozucu bulurlar, tipik olarak kendi duyguları ile çok fazla ilgilenirler, başkalarının duyguları ve durumlarına karşı çok fazla duyarsızdırlar.Psikoterapi suçluluk yaşadıkları dönemde yapılırsa etkili olabilir.Ancak uzun süreli prognoz iyi değildir.

48/84 Kodu (Ayrıca 48/84 kodu,Yüksek F ve Düşük 2 kodları, 482/842 kodları, 486/849 kodları ve 489/849 kodlarına da bakınız.)

Bu kod tipindeki bireyler sinirlilik, hostilite, şüphelenme ve olasılıkla referans fikirlerinin yanı sıra yoğun sıkıntı yaşamaktadırlar.Yansıtma ve eyleme vuruk davranışlar, asosyal yollarla ifade edilir.Sosyal açıdan izoledirler ve duygusal bağlanmadan korktukları için yakın kişiler arası ilişkilere girmezler.Bu bireylerin davranışları yordanamaz, değişkendir ve duruma uygun değildir.Cinsel kimlik sorunları vardır.Ciddi alkol kullanım öyküsü ve madde bağımlılığı olabilir.Yargılama bozuk, içgörü sınırlıdır.Sıklıkla intihar girişimi görülebilir.

Hem yetişkinler, hem de ergenler için bu kod tipi, marjinal sosyal uyumu olan ve kendini diğer insanlardan farklı hisseden bireylerde görülür. Ergenlerde bu kod çok geneldir ve en azından orta düzeyde ve belki de çok ciddi geçici uyum sorunları yansıtır. Diğerlerinde bu, prepsikotikbir süreci göstermektedir. Bu ergenler kızgın ve mutsuzdurlar, garip düşünce örüntüleri gösterirler, devam eden kişiler arası ilişki güçlükleri vardır ve uyumsuz biçimlerde

impulsiftirler.Akademik yönden başarısızdırlar ve suç işleyebilirler.Sıklıkla anoreksiya, aşırı hareketlilik ve enürezis ve enkoprezis öyküleri de vardır.Aşırı alkol alma, ilaç kötüye kullanımı görülmesine karşın bunlar bunları kullanma bağımlılık düzeyinde değildir.Bunlarla terapötik işbirliği kurmak zordur ve terapiden sıklıkla kaçınırlar ve/veya sorunların varlığını inkar ederler.

Bu koddaki yetişkinler, genellikle majör bir kişilik bozukluğu ya da psikotik br süreç gösterirler. Sosyal yargılamanın kötü olması, uyumsuzluk ve impulsivite, dışa vurma olasılığının artmasına nende olur.Okul ve iş öykülerinde başarısızlık ve marjinal uyum vardır.Bu bireylerin bazıları sosyal olarak soyutlanmış ya da göçebe hale gelirler.Diğerleri toplumun suçlu taraflarında yer alırlar.Bu koddaki bireylerin işlediği suçlar **(özellikle test 6 ve 9 da yüksekse)** sıklıkla anlamsızca yapılmış, zalim ve acımasızdır, kötü planlanmıştır ve sapkın cinsel davranışlar ya da cinayet işleme dönemlerini içerir.Bu koddaki erkeklerin açık suç davranışı içine girme olasılığı fazladır.Yaşlı erkeklerin cinsel sapkınlığı olabilir.Sıklıkla eyleme vuruk davranışlar sanki yakalanmalarını sağlayacak biçimde yapılır.

Kadınların sıklıkla istenmeyen gebelikleri ve her alanda başarısız olan erkeklerle ilişki kurma öyküleri vardır ve yeterlilikleri sınırlıdır.Bu kadınların benlik değerleri düşüktür ve daha az yeterli görünen kimselerle daha rahat ederler.Genellikle başkalarına cinsel olarak yaklaşmayı tercih ederler ve duygusal yakınlıktan kaçınır gibidirler.

Olası Tanı: Psikiyatrik yatan hasta ise şizofreni (Paranoid tip)

Borderline kişilik bozukluğu

Antisosyal, paranoid,şizoid kişilik bozukluğu

48/84 Kodu (Yüksek F/Düşük 2 Kodu)

Bu bireyler genellikle başkalarından farklı ve yabancılaşmış olmaktan dolayı rahattırlar ve başkalarına ebeveynlik ederler.Sıklıkla saldırgan ve cezalandırıcıdırlar ve başkalarını kontrol etmeye çalışırlar.Eğer zeka punaları ortalamanın üstündeyse diğerlerinde suçluluk ve anksiyete yaratarak onları manipüle edebilirler.Başka bir deyişle, bunların davranışları, katı bir disiplinden gerçek sadizme kadar geniş bir ranjda olabilir.Profildeki bazı bireyler(özellikle eğer K da yüksekse), bu özellikleri vurgulayan işlere girebilirler.(Yasa koyma ve yürütme, askeri uzmanlıklar vb...)Profildeki kişilere 'sosyopat kişilik' tanısı konabilir.

482/842/824 Kodları

Daha önce verilen 48/84 tanımlarına ek olarak, bu bireylerde depresyon,anksiyete, gerginlik, sinirlilik yaygındır.Bunların duyguları çok çeşitlidir, ancak genellikle suçluluk, aşağılık ve umutsuzluk duyguları görülür.İntihar girişimi göreceli olarak fazladır.

Kalıcı (uzun süreli) kişiler arası (özellikle heteroseksüel) yoktur.Genelde bu bireyler bekindir ya da sorunlu evlilikleri vardır, cinsel çatışmalar ya da güçlüklerle ilgili sorunlar yaşarlar.Bu insanların güçlü(hatta çoğunlukla abartılmış) ilgi ve sevgi gereksinimleri varsa da, başkalarına karşı güvensizdirler.Duygusal yaklaşımlar korku yaratır ve bireyler duygusal istekler ya da beklentilere karşı çok fazla duyarlıdır.

489/849 Kodları

Yüksek 9 testinin yanı sıra, 48/84 kod yorumlarının eklenmesi tuhaf, hatta garip ve öngörülemez şekillerde eyleme vuruk davranışların ifade edilmesi olasılığını arttırır.Davranışsal ajitasyon sıklıkla görülür;bu saldırma, savaşıma ve hatta şiddet gösterme biçiminde ortaya çıkar.

49/94 Kodu

Hem yetişkinler, hem de ergenler için, bu kod kendi isteklerini ön plana çıkarma ve sınırlar, kurallar ve düzenlemelere kızma ile bağlantılıdır.Benmerkezci, narsisistik ve bencildirler, hedeflerine ulaşmak için çok fazla enerji harcasalar da kendilerine verilen sorumlulukları kabul etmede isteksizdirler.Çoğu aktivitelerini haz alma, heyecan ve kısa vadeli hedefler üzerine yoğunlaştırırlar.Sosyal standartların ve değerlerin onlar için önemi çok azdır ve değerler konusunda bocalama yaşarlar ya da kendi değerlerini kendileri oluşturular.Birey 20 yaşın üstünde olduğunda, örüntü daha kalıcıdır ve daha fazla uyumsuzluk vardır.

Kısa kişilerarası bağlantılar ve sosyal durumlarda, bu bireyler sıklıkla iyi izlenim bırakırlar, çünkü enerji dolu ve güvenli görünürler ve güvnsizlikleri ya da kaygıları yok gibidir.Ancak, uzun süreli ilişki durumunda genellikle başkalarına bağlanmaları konusunda yüzeysel ve yapay ve hatta sorumsuz ve güvenilmez oldukları ve böylece insanlara yabancılaştıkları ortaya çıkar.Evlilik uyumları kötü olabilirve birçoğu evlilik dışı ilişkilere girebilir.

Bu koddaki ergenler tahmin edileceği gibi düşük bir engellenme eşiği vardır, ebeveynleri ile sık sık çatışırlar ve okuldan kaçarlar.Genellikle impulsif, umursamaz ve kışkırtıcı davranışlar(örneğin yalan söyleme, dolandırma ve hırsızlık gibi) gösterirler.İlaç ve aşır alkol kullanımı geneldir.Gençler sıklıkla tekrarlayan biçimde ailenin adına zarar verebilecek yasal ya da sosyal sorunlar içine girerler.

Eğer K testi 50 T puanının üzerinde ise ve/veya test 2, 5, 7 ya da 0 70 T puanı üstünde üçüncü yükselen test ise hem ergenler, hem de yetişkinlerde suç işleme ya da antisosyal davranış olasılığı daha azdır.**Alt test Si 50 T puanının altında olduğunda 49/94 özelliklerine sahip olsa bile** bireyin sosyal ilişkileri iyidir.Sıklıkla bu bireyler dışa vuruk davranışları göstermek yerine, diğerlerini antisosyal davranışlar yönünde manipüle ederler.

Bu kişiler için psikoterapi prognozu genellikle çok kötüdür, yaşla gelen olgunluk yaralı olabilir.Çocuğun geçmiş yaşantılardan ders alma yeteneği eksiktir ve arzularının doyumunu geciktirme yetenekleri yoktur.Çoğu tedaviyi erken bitirir ve tedavi sırasında genellikle sinirli ve düşmanca bir tutum sergilerler.

Olası Tanı: Antisosyal kişilikle birlikte bazı tip karakter bozuklukları
Pasif agresif kişilik bozukluğu agresif tip

493/943 Kodları

49/94 özelliklerine ek olarak, birey benmerkezcidir ve kendine yönelik içgöüsü yoktur.Bunlarda eyleme vuruk davranış olasılığı nadirdir ve olumsuz duygularını daha çok pasif-agresif ve dolaylı yollardan gösterirler.Alt test3 test 4'ün 5 T puanı alanı içindeyse 34/43 kod tipinin özellikleri de bulunabilir(bakınız 34/43 kodları). Böylece, bu koddaki bazı bireyler kızgınlıklarını sadece hiddetlenme şeklinde (genellikle bir aile üyesine karşı) açığa çıkarmak üzere biriktirebilirler.

495/945 Kodları

Alt test 5'in ek olarak yükselmesi ya bireyin açık ve küstah bir biçimde doğal olmayan bir cinsel yönelimi(genellikle homoseksüel)kabul etmesini gösterir ya da sıklıkla çok iyi eğitim görmüş, ilgi alanları geniş ve böylece impulsifliği ve isyankarlığı kontrol edebilmiş, daha sosyal bir bireyle bağlantılıdır.Bazen bu bireyler kendilerini var olan geleneklere karşı çıkan sosyal hareketler içine sokarlar.(Özellikle test 4 ve 9'un orta derecede yükseldiği ve test 7'nin de 70 T puanı ya da üstü olduğu durumlarda.)Böyle olsa da, bu bireyler kuralları,düzenlemeleri ya da diğerlerinin sıkı kontrolünü sevmeyen ve kendi özgürlüklerine ve kendi ilgilerine fazla değer verirler.

496/946 Kodları

Kod saldırgan,zarar verici ve hatta homisidal davranışı olan bireyi göstermektedir.(özellikle eğer test 8 de yükselmişse)Örüntü; bireylerde sıklıkla aniden garip biçimlerde ortaya çıkar ve bunlar daha sonra yanlış yaptıklarını ya da kendilerini zayıf hissettiklerini belirtirler.Yargılamaları ve olumsuz duygularını kontrolleri kötüdür(özellikle eğer K alt testi 50'nin altında ise).

498/948 Kodları

49/94 özelliklerine ek olarak, doğal olmayan, hatta tuhaf davranış olma sıklığı çok yüksektir.20 yaşın üstündeki bireylerde, bu kod genellikle majör ve uzun süreli bir psikopatolojiyi gösterir.

Ergenlerde, kod sıklıkla(bu kodda daha yaşlı bireylerde daha sıklıkla bulunan yeni başlayan ya da açık psikozdan çıkma) durumsal güçlükler ve yoğun bir ergenlik dönemi isyanı ile bağlantılıdır.

Ancak, hem yetişkinler, hem de ergenler yabancılaşma duyguları, aile çatışmaları, yüksek enerji düzeyleri, otoriteyle güçlükler ve isyankar davranışlar gösterirler.

40/04 Kodu

Koddaki bireyler hem kızgındırlar, hem de kişilerarası ilişkilerde geri çekilmişlerdir. Tipik olarak kızgınlıklarını açık biçimde ifade etmezler, uygun biçimde atılgan davranmada güçlükleri vardır ve kıskançlık duygularını içlerinde tutma eğilimindedirler. Şüpheli, küskün ve utangaçtırlar, pasif olarak direnme eğilimindedirler.

Yüksek puanla görülen bir depresyon durumu varsa bu çoğunlukla gerçek, psikomotor retardasyon ya da Negetatif depresyon belirtileri yerine depresif düşünce ve duygulara ilişkindir. Depresyon, davranışlarından dolayı suçlanmaktan çok, o andaki sınırlılıklar nedeniyle hoşnutsuzluktan kaynaklanır. Kendi davranışlarına olan ilgisizlikleri nedeniyle psikoterapötik yaklaşımda fazla etkili değillerdir. Kişisel olgunlaşma, diğer yaklaşımlardan daha etkili olabilmektedir.**Alt test 4'te yüksek puan alanlara** bazen kişilik bozukluğu tanısı konulabilir, ancak psikotik tanısı almazlar. Alt test 4'teki yükselme, suça ilişkin davranışlar ve hapse girip çıkma oranıyla pozitif korelasyon gösterir.

5-(M)KADINLIK-ERKEKLİK ALT TESTİ

Erkeklerde Mf değeriendirilmesi:

80 VE ÜSTÜ T PUANI:Lise eğitimi alan erkeklerde ya da kültürel baskı altındakilerde kültürün verdiği erkeksi rolle özdeşim olmadığını göstermektedir.Yüksek puanlar göreceli olarak pasif erkeklere (**eğer 4 alt testi de düşükse**) hatta bazı durumlarda kadınsı özelliklere sahip olanlara işaret etmektedir.

70-79 T PUANI:Bu erkekler hayal kurmayı seven, içedönük, eğitim yönelimli,spora özel ilgi duyan kişilerdir.Genellikle bu gruptaki erkekler idealist ve hayalperest bireylerdir, sosyal açıdan duyarlıdırlar ve kolay ilişki kurarlar.Eğitimi iyi olan ve kültürel açıdan zengin olan kişilerde bunlar beklenen özelliklerdir.

60-69 T PUANI:65 T puanının itsindeki yükselmeler demografik ve klinik veri dikkate alınarak değeriendirilmelidir.Üniversite öğrencilerinin bu aralıkta puan almaları beklenen bir durumdur.Ayrıca sanatla ilgili olanlar da(ressamlar, artistler)bu alanda puan alırlar.

41-59 T PUANI:Erkeksi ilgiler ve davranışlar olduğunu göstermektedir ve bütün ilgileri bu alanda daralmıştır.Maceracı kişilerdir, dışarıda yapılan aktiviteleri, sporu ya da mekanik aktiviteleri severler.Bu örüntüye düşük iş ilgileri eşlik eder.Ergen erkeklerde Mf düşüklüğünde, suç ve okul ile ilgili sorunlar eşlik etmektedir.

26-40 T PUANI:Erkeklerde maskülen görünmek için kompulsif bir uğraş vardır ve bu abartılmış bir boyuttadır.Narsisistik bir biçimde kendi güçlerini abartırlar.Bireyin kendi erkekliğini yoğun bir biçimde ortaya koyması, altta yatan kendine güvensizlik ile ilgilidir.

Kadınlarda Mf Değeriendirilmesi:

65 T PUANININ ÜSTÜ:Bu kadınlar güçlü, kuvvetli, saldırgan, yönlendirici ve yarışmacıdır.Geleneksel erkek rolüne özgü aktivite ve işlere girerler.Güvenli ve spontandırlar, ancak heteroseksüel ilişkilerin olduğu alanlarda ketlenmeleri vardır.Kadınsı cinsel kimliğe uyum sağlamalarının beklendiği durumlarda anksiyöz olabilirler.İddiacı, yarışmacı, inatçıdırlar ve diğer kadınlar gibi görünmek ve davranmaktan hoşlanmayan kişilerdir.Buna karşın davranış ve düşüncelerinde bağımsız, kendine güvenli, spontan, dominant ve saldırgan olabilirler.Kariyer ve iş ile aşırı uğraşma, erkeksi spor ve ilgi alanları ya da dominant,lezbiyen cinsel oryantasyonlar görülür.Kadınların çoğunluğu kendilerini kontrol edemeyecekleri durumlarda, özellikle karşı cinsle ilişkilerinde kontrolsüz bir durum varsa çok rahatsız hissederler.

Ergen kızlarda 5'in yükselmesi ev, okul ve yasalarla ilgili sorunlar olduğunu gösterir.14-19 yaşları arasındaki kızlarda 5 yüksekliği normal olabilir, ancak bu yaşlardan sonra oldukça nadirdir.5 yüksekliği sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ve farklı kültürlerden gelen kadınlarda da görülebilir.

56-65 T PUANI:Kadınlarda 60 ve üstünde T puanı onların aktif, atılgan ve yarışmacı olduklarını göstermektedir.

41-55 T PUANI:Bu kadınların ilgi alanları orta sınıf kadınların ilgilendikleri konular ile sınırlıdır.Duyarlı kişilerdir, bu duyarlılık erkeklerle ilişkilerinde daha da belirginleşmektedir.Giyimleri ile kadın olduklarını açıkça gösterirler.

26-40 T PUANI:Kadınların pasif, çekingen olduğunu göstermektedir.Mf düşüklüğü nevroitik üçlüde yükselme ile ilişkilidir.Eğer Pd yükselmesi, Mf düşüklüğüne eşlik ediyorsa seksüel impulsların olası eyleme vurukluğuna dikkat edilmelidir.Bu kadınlar herhangi bir şeyden mutlu olmamak için ellerinden gelen gayreti gösterirler.

Erkeklerde sadece Mf yükselmesi:Sadece test 5'in yükselmesi açık ya da örtük homoseksüaliteyi gösterme açısından yeterli değildir.Kendi homoseksüalitesini göstermek isteyen bireyler bu testte yavaş bir bir yükselme gösterirler.**Erkeklerde 5 testinde 75 T puanı ve üstü eğitim düzeyleri orta ya da lise 1 ise oldukça katı kültürel baskı varsa**, bu erkeklerde geleneksel erkeksi yaşam biçimi yoktur, yüksek puanlar pasif erkekleri gösterir(**eğer alt test4, düşük ise**) ve çoğunluğunda kadınsı özellikler vardır.

Mf KODLARI

51/15 Kodu(Bakınız 15/51 kodu)

52/25 Kodu(Bakınız 25/52 kodu)

53/35 Kodu(Bakınız 35/53 kodu)

54/45 Kodu(Bakınız 45/54 kodu)

56/65 Kodu

Bu kod tipindeki bireyler hakkında çok az bilgi vardır.Genel olarak duygularının incinsmesi konusunda aşırı duyarlıdırlar ve başkaları ile duygusal ilişkiye girmede kendilerine güvenmezler, bundan korkarlar.Eğer başkaları onlardan bir şey isterlerse sinirlenirler.Çoğunluğunun eğitim düzeyi yüksektir ve kariyer sahibi kişilerdir.

57/75 Kodu

Kararsız, endişeli, içedönük, gergin, mutsuz ve sürekli onay bekleyen erkelerdir.Eğitim düzeyi düşük olan erkeklerde, kendi yetersizlikleri ile obsesif ruminasyonlar,anksiyete ve depresif dönemler vardır.Karşı cinsle ilişkilerinde sıklıkla kendilerini yetersiz hissederler.Kadınlarda bu çok daha azdır, 5 testinde görüldüğünden çok daha az agresif ve daha çok kendilerini analiz eden kişilerdir.Entellektüel olarak yarışmacıdırlar.

58/85 Kodu

Bu koddaki erkekler içe dönüktür ve zamanlarının çoğunu düşünme ile geçirirler.Genellikle konfüzyonda, mutsuz ve diğerlerine yabancılaşmış oldukları duygusunu yaşarlar ve ev çatışmaları vardır.

59/95 Kodu

Erkeklerde 5'in yükselmesi açık eyleme vuruk davranışların azaldığını gösterir, burada entellektüalizasyon, inkarın, rasyonalizasyon aşırı kullanımı vardır.Aslında bu koddaki erkeklerin çoğu akademik olarak başarılıdır.Duygusal bağımlılık (anne bağımlılığı) ve benlik atılmalığının olmaması sorun alanlarıdır.

Kadınlarda 5 alt testinin yükselmesi saldırganlığın açığa çıkmasını gösterir, bu saldırganlık duruma bağlı sözel veya davranışsaldır.Bu kadınlar enerjik ve yarışmacıdırlar (erkeklerle

yarışır), kendilerine güvenirler, engellenmemiş ve maceracıdır, eğer onların istekleri sorgulanır ya da engellenmek istenirse sinirli ya da kendine dönük olurlar.

50/05 Kodu

Bu koddaki erkekler içe dönüktür ve genellikle kişisel ve entelektüel izolasyon yaşarlar, diğerlerine ulaşmak istemezler. Diğerleri ile ilişkilerinde temkinli, engellenmiş, içe çekilmiş ve kaygılıdır. Aşırı kontrollüdürler ve her şeyi aşırı idealize ederler. Sosyal açıdan beceriksizdirler, atılgan olma konusunda sorunları vardır, kendi yeterlilikleri konusunda hep sorgulama içindedirler. Karşı cinsle ilişkilerinde sorunlar ve rahatsızlıklar vardır.

Bu koddaki kadınlar tipik olarak daha az kendine güvenen, spontan ve güçlüdürler ve bu testin yükselmesinden beklenenden daha atılgandır. Sıklıkla kadınların eğitim düzeyi daha düşüktür, alt sosyo-ekonomik düzeyden gelirler.

6-(Pa) PARANOYA ALT TESTİ:

80 VE ÜSTÜ T PUANI: Kuşku, kızgın, küskün ve durumların doğrudan kendilerine yöneldiği biçimde yorum yapan kişilerdir. Bu bireylerin çoğu paranoiddir, referans fikirleri vardır, temel savunma mekanizmaları yansıtmaz. Gerçeği değerlendirme bozuktur, delüzyonlar, perseküsyon ve/veya grandiyöz biçimindedir.

70-79 T PUANI: Diğerlerini suçlama ve hostilite temel özelliklerdir. Bu bireyler katı, inatçı ve aşırı duyarlıdır. Kişiler arası ilişkilerde aşırı savunucu tutumları nedeniyle yanlış anlaşılabilirler. Açık paranoid özellikler vardır.

60-69 T PUANI: Duyarlı bireylerdir, kendilerinin ve diğerlerinin duygularının kolayca incinebileceği türünde düşünceleri vardır. Bu sıklıkla depresyonla ilgilidir. Diğerlerinden gelen eleştiri ve önerileri çok ciddiye alırlar ve kendilerinin söyledikleri her şeyin eleştiri gibi alındığı fikri vardır. Kişiler arası ilişkilerde savunucu ve diğer insanlara güvensizdirler, diğerlerinin kendilerinden yararlanacağını düşünürler. Kızgın, küskün olmaya hazırdır, çünkü en ufak bir olumsuzluğu üstlerine alırlar. İşte ve evde kendilerinden beklentiler konusunda kontrollüdürler.

45-59 T PUANI: Bu kişiler diğerlerini değerlendirmede esnekler. Onlara karşı duyarlıdır ve diğerlerinin kendilerinden beklentilerini doğru anlayarak olumlu yanıt verirler. **55-59 T puanı arasında olan** bireyler anlayışlı, duyarlı kişilerdir.

27-44 T PUANI: İki tip insan bu puanı verebilir. Diğerlerine duyarlılığı olmayan kişiler ve çok fazla şüphesi ve endişesi olan kişiler: Bunlar paranoya maddelerini atarlar. Diğerleri ise yüksek puan alan kişilerle aynıdır. Düşük puan alan bireyler geleneksel, güvenilir, kişiler arası ilişkilerde duyarlı, ilkel ve saftır. Zekaları sınırlıdır ve ilgi alanları daralmıştır.

Sadece Pa alt testinin yükselmesi: Bu bireyler aşırı duyarlı, katı, gergin ve kaygılıdır. Yaşamlarında iş ve sosyal baskı olduğunu hissederler. Şüphelilik, güvensizlik, düşüncelere dalma vardır. Yansıtma mekanizmasını sık kullanırlar. Sorunlara aşırı tepki verirler.

Pa KODLAMASI

61/16 Kodu(Bakınız 16/61 Kodu)
62/26 Kodu(Bakınız 26/62 Kodu)
63/36 Kodu(Bakınız 63/36 Kodu)

64/46 Kodu(Ayrıca 46/64, 462/642, 463/643 kodlarına ve 468/648 kodlarına bakınız.)

Bu koddaki bireyler immatür, narsisistik, pasif-bağımlı kişilerdir.Sosyal ilişki kurulması zordur.Diğerlerine öfke duyarlar ancak bunu kontrol edebilirler.Zaman zaman öfke patlamaları olur.Kızgınlıklarının suçuna başkalarına yüklerler.Diğer insanlara kuşkuyla bakarlar ve paranoid özellikler yaşarlar.Uzun zamandan beri sosyal uyumsuzluk gösterirler.Sonuç olarak psikolojik yardım için uygun kişiler değillerdir.64/46 kodunun yanında 8 alt testi de yükselmişse süreç daha kötü olur.Yukarıda özelliklere ek olarak bu hastalar psikolojik sorunlarını kabul etme yerine kaçma yolunu seçmektedirler.Mantık ve yargılamalarda da güçlükleri ortaya çıkmaktadır. Öfkeyle doludurlar ve bu da onların eleştiriye duyarlılık ve kıskançlıkları ile birleştğinde tahmin edilemeyen ve mantıksız öfke patlamalarına yol açar.Açık olarak her şeye karşı çıkar ve düşmancıdır. Davranış değişikliği için getirdikleri çözüm ise, karşısındakilerin kendi belirtilerine uygun bir şekilde davranış değiştirmesidir.

648 Kodu

Süreğen sorunlarına karşın savunucudurlar ve sorunlarında kendi rollerini inkar ederler. Huzursuz, şüpheli, narsisistik, sürekli isteyen rolündedirler. Rasyonalizasyon ve yansıtma savunma mekanizmalarını kullanırlar.Klinik olarak referans fikirleri, delüzyonlar, duygusal labilite ve kaygı görülür.İmpulsif, manipulatif davranışları olabilir.Otorite figürleri ile çatışma içindedirler.İntihar girişimleri, ilaç kullanımı olabilir.Profil tipi kroniktir.

65/56 Kodu(Bakınız 56/65 Kodu)

67/76 Kodu

Oldukça nadir görülür.Bireyler gergin, kaygılı, aşırı duyarlı ve sıklıkla çabuk küsen kişilerdir.Başkalarının kendilerine haksızlık ettiğini düşünerek ilişkilerini bozarlar.Aşağılık ve/veya suçluluk duyguları vardır ve bunu diğerlerine yansıtırlar.**Eğer 6 alt testi 7'den daha yüksekse ya da ikisi aynı düzeydeyse**, obsesif-kompulsif bozukluktan psikotik döneme bir geçiş olabileceği dikkate alınmalıdır.

Olası Tanı:Dekompanse obsesif kompulsif bozukluk

Alt test 6, 7'den daha yüksek ya da aynı düzeyde ise obsesif kompulsif bozukluktan şizofreniye geçiş olasıdır.

678/876 Kodları

6 ve 8, 7'den yüksek ise bu psikotik vadiyi oluşturur.Ciddi psikopatolojileri vardır.Şizofrenik bozukluklardan paranoid tip tanısı konulabilir.Halüsinasyonlar, delüzyonlar ve aşırı

şüphelerle birlikte görülür. Affektleri donuktur. Bunlar ürkek, içedönük, sosyal ilişkilerde çekingen ama alkol aldıklarında agresif olan kişilerdir. Bellek ve konsantre olmada sorunları olabilir. Fantezi ve hayal aleminde yaşarlar. Geçmiş ya da hayali hatalar üzerinde ruminatif biçimde düşünürler.

679 Kodu

Aşırı duyarlı ve katıdırlar. Sosyal ve iş yaşamlarında, kendilerini bastırılmış hissederler; şüphelidirler ve güvensizlik duyarlar, çabuk gücenirler ve öfke patlamaları vardır. İmpulsif dönemlerini, dönemsel suçluluk ve kendine yönelme izlemektedir.

68/86 Kodu (Ayrıca 468/648, 486/846, 489/849 kodlarına bakınız)

Bu kodu alan kişilerde yoğun aşâğılık duyguları dikkati çeker. Kendilerine güvenleri ve saygıları yoktur. Bu bireyler mutsuz, sinirli, negativist olarak tanımlanır.

Hem ergenlerde hem de yetişkinlerde bu kod ciddi psikopatolojiyi gösterir ve F alt testi de yükselmiştir, birey kabul edilmeyen yaşantılar getirir. Paranoid vadinin olduğu durumlarda paranoid şizofreni düşünülmelidir. Düşünce sürecindeki bozukluklar aşırı genellemeler, yanlış yorumlamalar ve delüzyonlarla kendini gösterir. Duygusal uygunsuzluk, aşırı idealleştirme, şüphe, güvensizlik, konsantre olmada güçlük, gerçek ile bağlantı kopukluğu ve bozuk kişiler arası ilişkiler vardır, bunlara depresyon ya da korkular ve fobiler eşlik eder. Bu bireylerin düşünce süreçleri garip olamamakla birlikte gerçeğe çok uygun değildir. Cinselliğe ilişkin içsel çatışmalar vardır. Tipik olarak sosyal açıdan içe çekilmiş ya da izoledirler (yetişkinlerin çoğu yalnızdır) e zamanlarının çoğunu kendi kurdukları fanteziler ile geçirirler. Eğer evli iseler, eşleri duygusal açıdan içe çekilmiş ve yabancısıdır. Davranış açısından bu bireyler yordanamaz, 4'ün yükseldiği durumlarda bu daha da zor olmaktadır.

Yetişkinlerin çoğu işlerini devam ettirirler, bu da oldukça şaşırtıcıdır. Yalnız herhangi bir dış etkenle bağlantılı olmadan yorgunluk, yetersizlik ve konsantre olamama ile belirgin psikotik dönemler görülür.

Ergenlerde genellikle saldırganlık nöbetleri (eğer K 50 T puanının altında ise) kötü arkadaş ilişkileri vardır. Zamanlarının çoğunu kavga etmekle geçirirler, derslerinde başarısızdırlar ve aile içinde ciddi cezalandırmalar ve dayak vardır.

Olası Tanı: Paranoid durum Paranoid şizofreni (6 ve 8 alt testleri 75 T puanının üstünde ise)
Şizoid kişilik

680/860 Kodları

Hastalarda paranoid şizofrenide görülen paranoid özellikler ve düşünce bozukluğu vardır. Sistemli hezeyanlar görülebilir. Hastalar gerginlik, kaygı, depresyon yakınmaları ile kişisel sıkıntılarını ifade ederler. Sosyal olarak izole ve çekiniktirler. Sosyal ilişkilerde düşmanlık ve şüphe hakimdir. Davranışlar genellikle sosyal açıdan uyum değildir ve önceden tahmin edilemez.

69/96 Kodu (Ayrıca 698/968 kodlarına bakınız.)

Hastalar gergin ve anksiyöz kişilerdir. Grandiözite ve egosantrik sezgiler içindedirler, heyecanlı ve enerjiktirler. Belirgin olan kızgınlık ve hostilitelerini, sosyal açıdan kabul edilebilir bir biçimde dışsallaştırmada güçlükleri vardır. Düşünce bozukluğunun varlığı halinde bunun manik ya da şizofrenik özellikler mi olduğu gözden geçirilmelidir.

Kod daha çok kadınlarda görülmektedir. Bu koddaki kadınlar gergin, daldan dala atlayan, küçük durumlara aşırı tepki veren kişilerdir. Durumları, kendileri için tehdit olarak alırlar. Gürültücü, ilgi çekici, sinirli ve şüpheli olma eğilimi içindedirler ve neyi, niçin yaptıklarını açıklama eğilimindedirler. Aile öykülerinde aşırı koruyucu ve sevecen bir anne vardır, ancak çok sert disiplin verirler. Baba genellikle karışmayan bir kişidir. Kadınlar duygusal ilişkiye girmekten korkarlar, diğerleri ile aralarına mesafe koyarlar. Eleştiriye aşırı duyarlıdır ve güvensizlikleri kroniktir. Bazen de kendilerini aşırı derecede duygusal ilişkiye gereksinimleri varmış gibi sergilerler, bu da çelişkili bir durumdur.

Olası Tanı: Manik bozukluğun bazı tipleri

Akut psikotik epizod

Alt test F ve Sc yükseğe paranoid şizofreni

694/964 Kodları

Hastaların sosyal, aile ve iş yaşamları hostilitelerine, yargılamalarının bozukluğuna ve duygularını kontrol edememelerine bağlı olarak bozuktur.İçgörülerini yoktur ve suçu diğerlerinin üstüne atma tipiktir.Saldırma, mücadele etme ve hatta cinayet potansiyeli değerlendirilmelidir.

698/968 Kodları

69/96 kodunda tanımlanan birey tipine ek olarak bu bireylerde ruhsal karışıklık, konfüzyon, düşünce ve dikkat toplamada güçlük vardır. Ayrıca delüzyonlar, paranoid şüphe ve halüsinasyon da vardır.

Eğer 8 alt testi, 6'dan 5T puanı aşağıda ise 68/86 koduna bakın.

Olası Tanı:Şizofreni paranoid tip

60/06 Kodu

Erkeklerde çok az görülür, genç kadınlarda hemen hemen hiç görülmeyebilir.Kadınlarda özellikle 30 yaşından sonra rastlanır.Bunu veren bireyler utangaç, içe çekilmiş, ve kişilerarası ilişkilerde huzursuzdurlar, diğerlerinin kendilerini sevmeyi ya da kabul etmediğini düşünürler.Eleştiriye aşırı duyarlıdır, kendilerini aşağılanmış hissettikleri için reddedilmeyi kolaylıkla kabul ederler.Duygularında oldukça mükemmeliyetçi ve aşırı kontrollüdür.

456 Alt Testlerinin Örüntüsü

Genellikle kadınlarda görülen bir örüntüdür.**Bu örüntüye alt test 3'ün yükselmesi eşlik ediyorsa**, bu tür kadınlarda, yüzeysel bir sosyallik, diğerlerine yönelik düşmanlık

duygularının inkarı söz konusu olabilir, diğerlerini kontrol ve manipüle etme davranış kalıbını yansıtır. Birey psikolojik yardıma dirençlidir.

7-(Pt)PSİKASTENİ ALT TESTİ

84 T PUANI VE ÜSTÜ:Bireyin ajite ruminasyonları, korku hali, obsesyonları ve kompulsiyonları ya da fobileri olduğunu göstermektedir. Anksiyete ve gerginlik o kadar fazladır ki günlük yaşamlarını bile devam ettiremezler. Entellektüalizasyon, izolasyon ve rasyonalizasyon sıklıkla kullanılmaktadır.

75-84 T PUANI:Temiz, titiz, düzenli kişilerdir. Önemsiz sorular karşısında bile gerginlik ve endişe yaşarlar. Kendilerini yetersiz, aşağılık duyguları ve suçluluğu olan kişiler olarak gösterirler. Bu kendilerine güvenmemelerine bağlıdır. Kendilerine ait bir fikirleri yoktur.

60-74 T PUANI:Bu yükseltirler dürüst, mükemmeliyetçi, titiz ve kendini eleştiren bireyler olduklarına işaret etmektedir. Küçük sorunları bile kendilerine dert etme eğilimindedirler.

45-59 T PUANI:Bireyler yaşamlarını ve işlerini endişe ve güvensizlik duymadan yürütebilirler.

20-44 T PUANI:Rahat, duygusal, gerginliği olmayan bireylerdir. Çoğu kendine güvenir ve uyumludur. Üretici ve yeterlidir. Kaygı düzeyleri çok düşük olduğu için sanki tembel gibi görünürler. Başarıya, statüye, kabul görmeye önem veren kişilerdir.

Sadece Pt alt testinin yükselmesi:Alt test 7’de yüksek puanlar, psikiyatrik grupta, genellikle kaygılı, gergin, kararsız ve dikkatini bir noktada yoğunlaştıramayan bireyleri tanımlamaktadır. Bu kişilerde obsesif düşünceler, ruminasyonlar, kendinden şüphe ve bunlara eşlik eden depresif özellikler vardır. Fobi ve kompulsif davranış, bu alt testte yüksek puan alan kişilerde görülebilmeye karşın, bu yüksek puanın karakteristiği değildir. Gerçekte, pek çok rijid kompulsif hasta alt test 7’yi yükseltmez. Çünkü bu kişilerin entellektüel savunmaları, anksiyetelerini ve güvensizlik duygularını kontrol edecek kadar güçlüdür. Daha çok entellektüel savunmaları, rasyonalizasyonları ve izolasyonları anksiyete ve gerilimlerini uzun süre kontrol edemeyen hastalar yüksek puan alırlar. Ayrıca alt testi 7’deki yüksek puanlar bedensel işlevlere karşı aşırı ilgiyi gösterir. Bu kişilerin yakınmaları daha çok kardiyovasküler sistemde yoğunlaşır. Ayrıca gastrointestinal işlevlerle ilişkili yakınmalara da rastlanır. Fiziksel yakınmaları, genellikle yüksek düzeydeki anksiyeteleri ve bunun bedensel işlevlere etkisini yansıtır. Terapötik yardımlardan önce anksiyetelerinin semptomatik tedavisi gerçekleştirilmelidir.

kodlar

71/17 Kodu(Bakınız 17/71 Kodu)

72/27 Kodu(Bakınız 27/72 Kodu)

73/37 Kodu(Bakınız 37/73 Kodu)

74/47 Kodu (Bakınız 47/74 Kodu)

Psikiyatrik hasta grubunda pasif agresif kişilik bozukluğu tanısı konulabilir. Kararsız, güvensiz kişilerdir. Sadece sinirli olduklarını belirtirler. Saldırganlıklarını kendilerine çevirdiklerinde depresyon görülür, ancak eyleme vuruk davranışları da olabilir.

75/57 Kodu(Bakınız 57/75 Kodu)
76/67 Kodu(Bakınız 76/67 Kodu)

Bu hastalar kaygılı, endişeli, kuşkucudurlar.Düşmanlık duygularını dolaylı yollardan ifade ederler.Gerçek paranoid değillerdir.Kişilik yapılarını değiştirmek zordur.

78/87 Kodu

Psikolojik yardım arayan kişilerde oldukça sık görülür.(Eğer 2 ve 4,8 alt testinin 5 T puanı altındaysa 278/728 ve 478/748 kodlarına bakınız)Bu kodu veren bireyler, nevrotik ve psikotik tanısı alabilirler.Yetişkinlerde 8 alt testi 7'den yüksekse, akut psikotik durum vardır.Ergenlerde 78 kodu 87 kodu kadar ciddi değildir.

Bu kodda olan bireyler endişeli, kaygılı, gergin, ve tekrarlayıcı ruminasyonları olan kişilerdir.Düşünce ve dikkatlerini toplama konusunda sorunları vardır.Stresleri o kadar fazladır ki, uykusuzluk ve intihar düşünceleri görülebilir.İntihar potansiyeli dikkatli bir içimde değerlendirilmelidir.8 alt testi, 7 alt testinden daha yüksekse intihar girişimi tuhaftır ve kendine zarar vermeyi içerir.Bireylerde halüsinasyon ve delüzyonlar, duygudurumda sıklık ve gerçekte bağlantıda güçlükler olabilir.Diğer işlevlerde yıkım vardır, ancak bunlar psikotik davranışlar şeklinde değildir.Bu durumda olan hastalar ciddi düşünce ve davranışları onları rahatsız etmektedir.Yakın kişilerarası ilişkiler kurmada güçlükleri vardır.Genelde içedönük ve çekiniktirler.Bu özellikler de onların obsesif ruminasyonlarını arttırmaktadır.Düşünce bozukluğunun var olup olmadığı araştırılmalıdır.Psikofarmakolojik müdahale bunların yoğun anksiyetelerini azaltmakta faydalı olabilir.Psikolojik müdahale güçtür, çünkü bunların psikolojik çatışmaları kroniktir ve bundan dolayı kişilerarası ilişki zorlukları vardır.

Karşı cinsle ilişkilerde kendilerini yetersiz hissederler.Yoğun kaygıya bağlı olarak cinsel performansları kötü olabilir.Bu bireylerin çoğu gevşemek için aşırı alkol alabilirler.

7, 8'den büyükse;

Olası Tanı:Birey düşünce ve davranış bozukluğu geliştirmemek için hala savaş vermektedir.

7, 8'den küçükse;

Olası Tanı: Her iki yükselme de 75 T puanının üstünde ve 8 alt testinde belirgin bir yükselme varsa tanı şizofrenidir. İntihar girişimi varsa tuhaf, kendini kesme ve cezalandırmayı içermektedir.

782 Kodu:Olası Tanı: Depresif Bozukluk.Obsesif Kompulsif Bozukluk

872 Kodu:Olası Tanı:Şizofrenik Reaksiyon

784/874 Kodu:Olası Tanı:Şizofrenik Reaksiyon, Şizoid Kişilik Bozukluğu

789 Kodu

Hostil, gergin, şüpheli, hiperaktif, huzursuz bireylerdir.Günlerini fanteziler ve hayal kurmayla geçirirler.Yansıtmayı kullanır, uygunsuz duygudurum gösterirler.Sınırlı sosyale yaşantıları

vardır.Diğerlerinden çocuksu tarzda ilgi ve sevgi beklerler, istekleri gerçekleşmediğinde ise gücenip, düşmanca davranırlar.Yakın duygusal ilişkiye giremezler.Kendilerine ilişkin grandiyöziteleri vardır, kendileri ile övünürler.Başarıya ulaşma isteklerinin çok fazla olmasına karşın orta düzeyde performans gösterirler.

79/97 Kodu

Bu oldukça az görülen bir koddur.Bu bireyler ajitasyon düzeyinde kaygı yaşarlar.Korkuları vardır, olaylara aşırı tepki verirler, korkularına ve yetersizliklerine bağlı olarak kendilerini gevşetmeleri ve bunlardan kurtulmaları mümkün değildir ve aşırı ruminasyonlar gösterirler.Eğer 2 alt testi de yükselmişse depresyon görülür, ancak klinik tabloda anksiyete ve gerginlik ön plandadır ve hastalar sıklıkla fiziksel semptomlar(örneğin sırt ağrısı, kas spazmları ve uykusuzluk)getirirler. Bazı bireylerde manik örüntü vardır ve bu farmakolojik müdahale gerektirir.

Bu kodu alan ergenlerin yoğun ilgi gereksinimleri vardır, ancak kontrolü kaybedeceklerini düşünerek böyle bir şey yapmaktan kaçınırlar.Ayrıca ergenlerde bağımlılık, bağımsızlık çatışması çok fazladır.

794 Kodu

Hastalar kronik olarak kaygılı ve gergindirler.Yüksek enerji düzeyleri obsesif ruminasyonlarına katkıda bulunur.Konuşmalarının genellikle izlenmesi zordur, bağlantısız fikirler görülür.İmpulsif dışa vurma dönemleri birbiri ardına sıralanır.Diğer manik özelliklerin de birlikte görülüp görülmediği araştırılmalıdır.

70/07 Kodu

Bu profili veren kişiler utangaç, içedönük, sosyal becerilerden yoksun, gergin ve endişelidirler, uykusuzluktan yakınırlar.Oldukça nadir görülür.

Bu koddaki erkekler sosyal yetenekler ve/veya fiziksel görünimleri konusunda endişeli ve gergindirler, kendilerini yetersiz görürler.Çoğunluğu içedönüktür, bu sözelleştirmeyi de engeller.Güvensizlikleri ve karar verme güçlükleri onları konfüzyonda bırakır, aşırı kontrollüdürler ve kendilerini suçlarlar.Ruminasyonları uykusuzluk ile sonlanır.Anneleri ve kardeşleri ile yoğun çatışmaları vardır.Sosyal alandaki yetersizlikleri, karşı cinsle olan ilişkilerini de etkilemektedir

Kadınlarda eğer 5 alt testi, 40 T puanının altında ise aynı örüntü vardır.Bunlar yoksa sorunların ciddilik oranı daha azdır, kendilerinin ne olduğunu farkındadırlar.Fiziksel görünüm olarak çekici olmadıklarını düşünürler ve sosyal açıdan güvensizlik ve karşı cinsle rahat ilişki kuramama gibi sorunları vardır.

8-(Sc)ŞİZOFRENİ ALT TESTİ

100 T PUANI VE ÜSTÜ:Akut bozukluğun eşlik ettiği uzun süreli ciddi bir stresin sonucunda ortaya çıkar.Bu kişiler tipik olarak şizofren değildirler.Daha çok akut psikotik reaksiyon içine giren hastalardır.Ayrıca kimlik krizindeki ergenlerde de bu aralığa rastlanır.**T 95'ten büyük olan değerler** akut durumsal stres ve ciddi özdeşim krizlerini gösterir.

75 T PUANI VE ÜSTÜ: Yabancılaşma yaşayan ve doğru düşünemeyen bireyler tarafından verilir. Düşüncede ve hareketlerinde sıradan değildirler, olasılıkla sosyal açıdan çekiniktirler ve derin kişilerarası ilişki kuramazlar. Kendilerinin kim olduğu ve bu dünyadaki yerlerinin ne olduğu konusunda oldukça bozuk düşünceleri vardır ve genellikle bu dünyaya ait olmadıklarını düşünürler. İletişim kurmada sorunlar temeldir, dezorganize düşünceleri vardır ve bunlar açık ve mantıklı düşünmesini engeller. Bireylerin gerçek ile bağlantısı var gibi görünse de bu oldukça yüzeyseldir. Alt test 8'deki yüksek puanlar, gerçek psikotik düşünce bozukluğunu yansıtabilecek soğuk, apatik, yabancılaşma, düşünme, iletişim ve anlamada bozulma olması gibi özellikleri gösterebilir. Kişiler arası ilişkiler yerine hayalleri ve fantezileri yeğlerler. Aşağılık duyguları kendilerinden hoşnutsuzluk ve yalnızlık duyguları içindedirler. **T puanı 80'e yaklaştığında** mantıkta ve düşünmede tuhaflık belirginleşir. Gerçek şizoid düşünce süreci gözlenebilir. Bunlara depresif özellikler ve psikomotor gerileme eşlik eder. Davranışlar ya şizofrenik bir sürecin ya da şizoid bir uyumun ya da uzun süreli ciddi bir stresin sonucu olabilir.

60-74 T PUANI: Bu yükselme değerlendirilirken profilin tümü ele alınmalıdır.

1-Bu yükselmenin alt sınırında ve nevrotik profillerde yükselme varsa bireyin soyut konularla ilgilendiğini göstermektedir. **Eğer Si alt testi de yükselmişse** diğerleri tarafından uzak ve anlaşılmaz kişiler olarak tanımlanmaktadır.

2-65-74 T puanı aralığındaki değerlendirmede genel bir yabancılaşma ya da örtük psikoz olup olmadığı araştırılmalıdır. **F ve Pa alt testlerindeki yükselme psikoza eşlik eder.**

3-Orta düzeyde yükselmeler eğer diğer psikotik belirtiler varsa (F,4,6,9,nevrotik alt testlerinin yükselmesi) şizoid sosyal uyumu ve bireyin dünyaya kendine özgü bakışını göstermektedir.

45-59 T PUANI: Bu bireylerin kuramsal ve pratik görüşlerini normal bir biçimde bir araya getirdiklerini göstermektedir.

21-44 T PUANI: Pratik ve gelenekseldirler, davranışları ve yaşama bakışları konservatiftir. Genellikle bireyler uyumlu, sorumlu, bağımlı ve temkinlidir, ancak hayal güçleri yoktur ve oldukça katıdırlar. İlişkilerinde çekingen, derin duygusal ilişkilerden kaçınan, temkinli, tutucu, rekabet etmek istemeyen kişilerdir.

81/18 Kodu(Bakınız 18/81 Kodu)

82/28 Kodu(Bakınız 82/28 Kodu)

83/38 Kodu(Bakınız 83/38 Kodu)

84/48 Kodu(Bakınız 84/48 Kodu)

85/58 Kodu(Bakınız 85/58 Kodu)

86/68 Kodu

6 ve 8'in T puanı 80'in üzerinde, 7 de 70 T puanındadır. Bu profil psikiyatri hastalarında sık görülür.'Paranoid vadi' ya da 'Psikotik V' olarak adlandırılır.

87/78 Kodu

Endişeli, kendi kendini tetkik edebilen, derin düşünceye dalan kişilerdir, kişilik güçlükleri kroniktir. Bağımsız, kendine güvenen kimseler değildir, daha çok pasif bağımlıdır. Cinsel sorunları vardır. Olgun ve yakın ilişkiler kuramazlar, öğrendikleri şeyleri bağdaştıramazlar.

8726/Yüksek 9 Kodu

Ajite şizofren bir hastayı göstermektedir

89/98 Kodu

Bu kod tipi ergenlerde ve yetişkinlerde ciddi psikopatolojiyi gösterir. Benmerkezcidir ve başkalarından çocuksu beklentileri vardır. Aşırı derecede idealize kişilerdir, günlerini fanteziler, hayal kurmalar ve ruminasyonlarla geçirirler. Gerginlik, ajitasyon ve uykusuzluk vardır. Genellikle çok konuşma, davranışsal huzursuzluk, duygusal labilite ve fikir uçuşmaları görülebilir. Kişilerarası ilişki durumlarında(örneğin, terapi görüşmelerinde) konudan konuya atlarlar. Terapötik odaklanma mümkün değildir. Kişilerarası ilişkilerinde özellikle karşı cinsle ilişkilerinde huzursuzluk, oldukça tipiktir. Bireyler yakın kişilerarası ilişkilerden korkarlar ve bu nedenle de bu tür ilişki kurmak istemezler. Stres altında dağılma belirtileri vardır. Kod daha da yükselirse delüzyon ve halüsinasyonlar görülür, psikotik bir tablo ortaya çıkar. Yaşı 27'den küçük olanlarda görülür

Olası Tanı: Şizofreni

Madde kullanımına bağlı psikoz

80/08 Kodu

Genellikle sosyal açıdan çekingen kişilerdir.Kişilerarası ilişkilerde hata yapmak istemedikleri için ilişki kurmaktan kaçınırlar.Fantezi kurarak zamanlarını geçirirler.Sosyal izolasyonları o kadar fazladır ki kendi ailelerinden bile uzaklaşırlar.Bunun yanı sıra endişeli, karasız, kaygılı, depresif ve diğerleri tarafından yanlış anlaşılan kişilerdir.Kendilerini neyin rahatsız ettiği, diğerlerinden ne istedikleri konusunda konfüzyonları vardır.Atılğan değildirler.Danışmanlık görüşmelerinde genellikle konuşmazlar.

Olası Tanı: Şizoid Kişilik

9-(Ma) HİPOMANİ ALT TESTİ

85 T PUANI VE ÜSTÜ:Ajitasyon yada manik dönem olabilir.Birey hiperaktiftir, davranışları yordanamaz, fikir uçuşmaları vardır.Kendilik değerini abartır.

70-84 T PUANI VE ÜSTÜ:Enerjik, konuşkan, eylemi düşünceye tercih eden kişilerdir.İlgileri çok geniş bir alana yayılmıştır ve hemen gerçekleştirmek istedikleri çok sayıda projeleri vardır.Bu kişilerin çoğunda aktivite ve güç, abartılı düzeyde yüksektir, ancak projelerini tamamlayamazlar.Tipik olarak davranışlarını, düşmanlık duygularını ve öfkelerini kontrol edemezler.Gerçek manik özellikler gösterebilirler.Fikir uçuşması, duygudurumda kaymalar ev değişmeler, büyüklük sanrıları ve hiperaktivite gibi.

Ergenlerde bu yükselme, artmış hareketliliği gösterir.İmpulsif ve kontrolsüzdürler.Grandiözite ve çağrışımlarında artmalar vardır.İletişim güçlükleri ve suça eğilim görülebilir.

60-75 T PUANI:Enerjik, dışadönük ve aktif bireyleri gösterir.Bunlar, diğerleri tarafından hoş ve yeterli olarak görülürler.Bu düzeydeki puanlar lise veya lise mezunu öğrencilerde çok sıktır, çünkü bu bireylerde enerji düzeyinin yüksek olması beklenen bir durumdur.Kişiler onay ve statü kazanmak için çaba harcarlar ve düşünce ve davranışlarında özgür olma eğilimleri vardır

60-69 T PUANI:Hoş, enerjik,meraklı, sosyal, kolay ilişki kuran, ilgi alanları geniş kişilerdir.Bu hallerinden kendileri de memnundur.İyimserlik, bağımsızlık ve kendine güven vardır.

45-59 T PUANI:Normal aralığıdır.Puan normal aralıktan yükseldikçe mani düzeyinin arttığı düşünülür.Bu şekilde, puanlardaki artış maniye,giderek hipermaniye işaret eder.Manik hastalar davranışlarından kolaylıkla tanınabildikleri için, alt test, daha çok ortalarda puan alan hastaların teşhisinde yardımcı olabilir.

21-44 T PUANI:Düşük enerji düzeyi, güdü azlığı hatta apatiyi gösterir.Bu geçici yorgunluk yada hastalığa işaret etmektedir.Düşük puanların çoğunluğu, kronik açıdan düşük enerji düzeyinin belirtisidir.Bireylerin kendilerine güvenleri azdır ve genellikle amaçları yoktur.Sabahları kalkmak istemezler ve herhangi bir projeye başlarken aşırı çaba sarf etmek zorunda hissederler.Özellikle 2 alt testinin yükselmediği durumlarda depresyon düşünülmelidir.Yaşlı insanlarda 9'un düşüklüğü beklenen bir durumdur, normal yaşlanma sürecini gösterir, 45 yaşın altında düşük olması beklenen bir durum değildir ve dikkat edilmesi gerekir.

Ma KODLAMALARI

Eğer 9 ve K alt testlerinde puanlar 70T puanında (2 alt testi T:50'nin altında ise)bu kişiler enerjik, organize, diğerlerinin kendileri üzerinde otorite kurmalarını istemeyen kişilerdir.Genellikle çok iyi yöneticidirler.Güç yönelimli bireylerdir, bunlar için belirsizlik, fikir üretmemeye ya da çelişkili durumlar tahammül edilemez şeylerdir.Kendilerinin kontrol edemediği durumlarda ve bilgi verilmeyen, yapılanmamış durumlarda rahatsız olurlar.

Bu bireylerin çoğu yarışmacıdır.**K alt testi 70T puanının üzerinde çıkarsa**, kendi yaşamlarını ve çevrelerindeki diğer kişilerin yaşamlarını organize etme çabaları vardır.Kendilerini rahatsız ya da tehdit eden durumlarda bağımlı, itaatkar, duygusal ve kontrolü kaybeden kişiler olabilirler.Bireyler diğerleri üzerinde kontrol koyarak onları kendilerine itaat ettirirler. Aslında temelde kendilerine güvensizdirler, rollerine, görünümlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar.Kadınlar fiziksel çekicilik konusunda teşhircidirler(**Eğer 5 alt testinde T:40'ın altında ise**), böylece kendilerini kabul ettirir ve diğerlerini kontrol ettiklerini düşünürler.

Yüksek 9/Düşük K Kodu

Narsisistik kişilerdir.Kadınlar, eksibisyonist bir biçimde kendilerini sergileyerek dikkatleri bu şekilde üstlerine çekerler.

91/19 Kodu(Ayrıca 19/91 Koduna da Bakınız)

Ender görülmektedir.Hastalar hipomanik durumdadırlar, ancak gergindirler ve yerlerinde duramazlar.İhtiraslıdırlar.Başarısızlıkla engellenmişlerdir.Hipokondriak sorunlarıyla karşılaştıkları durumsal güçlükler arasındaki ilişkiyi ispatlamak kolaydır.

92/29 Kodu (Bakınız 29/92 Kodu)

93/39 Kodu (Bakınız 39/93 Kodu)

94/49 Kodu (Bakınız 49/94 Kodu)

Eyleme vuruk davranışlar ile ilgilidir.

95/59 Kodu (Bakınız 59/95 Kodu)

96/69 Kodu (Bakınız 69/96 Kodu)

97/79 Kodu (Bakınız 79/97 Kodu)

98/89 Kodu (Bakınız 89/98 Kodu)

90/09 Kodu

Kod oldukça nadirdir, özellikle erkeklerde çok az görülür.Bu koddaki bireyler enerjik ve olasılıkla ajitedirler.Genellikle yalnız kişilerdir.Si alt testinin yükselmesi bırakılarak yorum, yükselen diğer iki alt test ile yapılmaktadır.Daha sonra eğer gerekliyse Si alt testi yorumlanmalıdır.

0-(Si)SOSYAL İÇEDÖNÜKLÜK

70 T PUANIVE ÜSTÜ:Sosyal açıdan beceriksiz olan kişilerdir.Sosyal ilişkilerde anksiyete yaşar ve ilişki kurmaktan kaçınırlar.

60-69 T PUANI:Bu kendini ortaya koymak istemeyen, yakın aile çevresinde rahat olan bireylerin profilidir.Çekingen, utangaç kişilerdir.

45-59 T PUANI:Sosyal ilişki kurmada başarılı olan bireylere işaret etmektedir.

25-44 T PUANI:İyimser, manipülatif, yüzeysel ve hatta biraz uçuk bireylerdir.Dürtü kontrol sorunları vardır.Diğerleri ile olmak isteyen, yalnız kalamayan bireyleri gösterir.Çoğu kolay ilişki kurar, arkadaş canlısı ve meraklıdırlar, sosyal açıdan kabul görme, onaylanma konusunda gereksinimleri çok fazla olan bireylerdir.

01/10 Kodu (Bakınız 10/01 Kodu)

02/20 Kodu (Bakınız 20/02 Kodu)

03/30 Kodu (Bakınız 30/03 Kodu)

04/40 Kodu (Bakınız 40/04 Kodu)

05/50 Kodu (Bakınız 50/05 Kodu)

06/60 Kodu (Bakınız 60/06 Kodu)

07/70 Kodu (Bakınız 70/07 Kodu)

08/80 Kodu (Bakınız 80/08 Kodu)

09/90 Kodu (Bakınız 90/09 Kodu)

049 Kodu

Psikiyatrik olgularda eyleme vurukluğun bastırılması

027 (8) Kodu

Bireyde güçlü ruminatif davranışlar görülebilir.

F-K endeksi 16 ‘nın üstünde ise:

Geçerlilik konfigürasyonu bu hastanın test bulgularının değerlendirilmesinde dikkatli olmanın gerekliliğini göstermektedir. Yapılan standart değerlendirme hastanın durumunu yansıtmayabilir Bu veri için olası açıklamalar şunlardır:

*Hasta akut bir psikotik bozukluk göstermektedir ve testi içinde bulunduğu duruma bağlı olarak tamamlayamaz.Klinik düzelme olduktan sonra test yinelenmelidir.

*Birey bilinçli olarak durumunu abartmakta ya da bir yarar sağlamak için simülasyon yapmaktadır.

(?) "Hiç Bir şey diyemem" Skalası:

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
0	44 ve alt?	Düşük

Bu bireyler bütün maddeleri yanıtlamaya isteklidirler. Birçok kişinin bu performansta olması beklenir.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
1-5	45-59	Normal

Bu bireyler özellikle kendileri için önemli olan konulardaki soruları boş bırakmışlardır. Bunların içeriği göz önüne alınmalıdır.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
6-30	60-69	Orta

Bu bireyler çok sayıdaki maddeyi boş bırakmışlardır. Boş bıraktıkları maddelere yeniden bakmaları istenir. Aksi taktirde profilde yüksek nokta çiftlerinde yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Yaklaşık 30 madde boş bırakılmışsa geçerliliği sorgulanır.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
31 ve üstü	70 ve üstü	Belirgin

Bu profil büyük bir olasılıkla geçersizdir. Birey M.M.P.I. 'ı tamamlamaya muktedir değildir veya isteksizdir. Kendilerine ilişkin önemli bilgi vermemeye çalışıyor olabilirler. Obsesyonel tarzda karamsarlık nedeniyle yanıt verememiş olabilirler. Veya, sadece bu maddeleri yanıtlama konusunda isteksizdir. Eğer, mümkünse klinisyen, danışana testteki boş maddeleri doldurması için güdülemelidir.

L SKALASI (Yalan) :

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
0-2	44 ve altı	Düşük

Bütün maddelerin doğru yanıtı verilmiş olabilir. Diğer geçerlilik skalaları değerlendirilmelidir. Bu bireyler, kendileri hakkında aşırı bir patolojik tablo çizmeye çalışıyor olabilir. Çok küçük sosyal hatalarını bile kabul etmeye istekli olan, bağımsız ve özgüvenli normal kişiler bu kategoride yer alabilir.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
3-5	45-59	Normal

Bu bireyler, küçük sosyal hataları kabul etme ve reddetme dengesi açısından başarılıdır. ideal benlik imajı yordamaya çalışan kişiler bu grupta yer alır.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
6-7	60-69	Orta

Diğer geçerlilik skalaları değerlendirilmelidir. Normalden daha rahat kişiler veya inkar mekanizmasını çare olarak kullananlar bu grupta yer alır.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
8-15	70 ve üstü	Belirgin

Puanlamada bir hata olabilir. Örneğin; yanlış cevaplarının yerine doğru cevaplar? sayılmış olabilir. Bu ranjda puan alanlar, çok fazla benlik kontrolü olan ve kendi davranışlarına iç gözü eksikliği olan ve dini veya ahlaksal eğitim alan veya çok yaygın insan hatalarını inkar eden veya personel seçiminde ideal izlenim vermek için çaba gösteren eğitimsiz kişiler, inkar mekanizmasını çok kullananlar (sıklıkla histerik ve hipokondriyak durumlarda karşılaşılır), zenciler ve yorumun ne olarak kullanılacağını bilmeyen diğer azınlık grupları bu kategoride yer alır.

K PUANI (Psikopatolojiden Şüphelenmesi ve Bilinmesi) :

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
0-4	27-35	Düşük (Belirgin)

Bu türe girenler ya problemlerini aşırı olarak abartmakta, aşırı duygusal problemi var izlenimi yaratmakta ya da uydurmaktadırlar. Akut psikotik stres yaşıyor olabilirler. Hastaneye yatırılmaları gereklidir. Psikolojik yaklaşım için prognez son derece olumsuzdur.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
5-9	36-45	Düşük

Aşırı stres nedeniyle kişisel kaynakları sınırlanmış bireylerdir. Bu bireyler, kötü benlik kavramına, aşırı şekilde benlik doyumsuzluğuna, ancak bunları değiştirmek için gereken hüner veya teknik yetersizliklerine sahiptirler. Ayrıca, bu kategoride aşırı derecede açık ve mazoistik eğilimleri olanlarda yer alır. Alt sosyo ekonomik sınıftaki bireylerde bir yükselme orta düzeydeki bir bozukluğu yansıtırken, üst sosyo düzeydeki bireylerde düşük ego gücünü ve ciddi stres durumlarına işaret eder. Psikolojik yaklaşımda prognez sınırlıdır.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
10-15	46-55	Normal

Benliğini açma ile saklama arasında uygun dengeye sahip kişilerdir. Psikolojik yaklaşıma açıktırlar. Üst sınıftaki kişilerde orta düzeyde kişisel stres düşünülüne bilinir. Psikolojik yaklaşımda prognez iyidir.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
16-20	56-65	Orta

Bu bireyler, savunmacı ve psikolojik strese kabule isteksizdirler. Özellikle alt sınıf bireylerde bu savunmalar inkar ve histerik savunmalarla karakterize edilir. Klinisyen, K puanı ile düzeltilmiş skalalarda K puanının skala değerini aşırı yükseltmesi nedeni ile K ile düzeltilmemiş profilleri kullanmalıdır. Prognez sınırlıdır.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
21 ve üstü	66 ve üstü	Belirgin

Bu bireyler problemlerini ve zayıflıklarını kabule isteksiz, kontrollü kişilerdir. iç görü eksikliği vardır. Aşırı derecede savunmacıdırlar. Yetersizlikler profile yansımıyor olabilir. Ancak son derece yetersiz kişilerdir. Klinisyen, bireyin psikopatolojisini inkar edenleri araştırmalıdır ve K ile düzeltilmemiş profilleri kullanmalıdır. Prognez çok kötüdür.

NORMAL KİŞİLERDE K PUANI:

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
0-9	27-45	Düşük

Problemlerle ilgilenmekte s?n?rl? kaynaklara sahip kiřilerdir. Klinisyen bireyin ger?ekten normal olup olmad???n? arařt?rmal?d?r.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
10-15	46-55	Normal

Alt sosyo-ekonomik seviyeden gelen bireyler veya benlik a?ma ile benli?i koruma aras?nda uygun dengeye sahip az e?itimli kiřilerdir.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
16-20	56-65	Orta

Bu bireyler, iyi uyumlu, i? g?r?l?l?, ?z g?venli, g?nl?k problemleriyle kolayl?kla bař edebilir; ?st s?n?ftaki kiřiler, ?niversite ??rencileri veya ?niversite e?itimi alm?ř kiřilerdir. Stres alt?nda bu kiřiler, problemleri i?in yard?m aramada isteksiz olurlar.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
21 ve ?st?l?	65 ve ?st?l?	Belirgin

Bu bireyler, uyum ve benlik yetersizli?i konusunda savunmac? ?zellikler g?sterirler. Bu y?nlerin uygunlu?u soruřturuldu?unda pek ilgi g?steremezler.

FE SKALASI:

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
0-2	44 ve altı	D?ř?k

Bu bireyler, dikkatli bir tarzda sosyal olarak kabul edilmeyip veya rahatsız edici nitelikteki skala sorularına bilgi vermekten ka?ınmıřlardır. Ciddi psikopatolojilerini inkar etmeye ?alıřıyor olabilirler. Veya ařırı geleneksel, iddialı olmayan normal kiřilerdir.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
3-7	45-59	Normal

Bu bireyler, tipik sayıda uygun olmayan yařantıya iliřkin bilgi vermiřlerdir.

<u>Ham Puan</u>	<u>t</u>	<u>Yorum</u>
-----------------	----------	--------------

8-15

60-69

Orta

Bu bireyler, tipik kişilerden daha fazla sayıda uygun olmayan yaşantıya sahiptirler. Yükselme, psikopatolojinin miktarına ve şekline ilişkin bilgi verir ve bireyin psikopatolojisine nasıl uyum sağladığını gösterir. Psikotik hastalar, çoğunlukla bu ranjin ortalarında yer alırlar.

Ham Puan

t

Yorum

16-22

70-89

Belirgin

Profil geçersiz olabilir. Diğer geçerlilik skalalarına bakılmalıdır. Bu yüzdende bireyin psikopatolojisinin miktarı ve şekline ilişkin bilgi verir. Bu hastalar yaşlarına ve gördükleri tedavi türüne göre davranış bozukluğu veya psikotik tanısı almışlardır. Ergenler (suçlu olarak etiketlenmemiş olanlar) bozuk davranışlarını dürüstçe işaretlemiş olabilirler.

Ham Puan

t

Yorum

23 ve üstü

90 ve üstü

Aşırı Belirgin

Profil geçersizdir. Diğer geçerlilik skalaları gözden geçirilmelidir. Bu bireylerin dezorganize ve psikotik olma olasılığı fazladır. Görüşme, tanı koydurucudur. Kimlik krizine girmiş ergenler, bu ranjda yer alabilir.

*** NOT :** Çocuklara verilen testlerde (C.A.T.) testin içeri?inden çok çocukla kurulan raport önemlidir.